

分类号

密级

UDC

编号

中央财经大学

硕士学位论文

学位论文题目：基于嵌入性治理视角的社区养老服务模式
研究——以北京市朝阳区为例

姓 名 黄祖良

学 号 2020211874

学 院 政府管理学院

学位类别：☐学术硕士 ☒专业硕士 ☐同等学力

学科专业 公共管理

指导教师 邢华教授

第二导师

提交论文日期： 2022 年 5 月 3 日

基于嵌入性治理视角的社区养老服务模式研究
——以北京市朝阳区为例

Community elderly care service model based on
the perspective of embedded governance, Taking Chaoyang
District, Beijing as an example

内容摘要

21 世纪以来,我国已迈入人口老龄化社会,老年人口不仅数量规模大,增长速度快,而且呈现出高龄化、失能化、空巢化等特征,养老领域的问题正受到社会各界的普遍关注。随着我国社会经济的发展和家庭结构的转型,老年人的养老需求日趋多样,而在我国的社区治理中,土地、资金、人力等资源的紧缺给养老服务带来了前所未有的压力。长期以来,由于受儒家思想的熏陶,主张“养儿防老”的家庭养老服务模式在我国根深蒂固,但是随着生育率下降、家庭类型分化、未富先老等方面冲击,该模式的养老功能正不断弱化。同时机构养老服务模式一般选择在郊区设立大型的专业养老机构,配备先进的养老设施和充足的医护人员,能让老年人享受到规范化养老服务,却受限于服务价格、位置距离、情感隔阂、社会认知等因素,未能充分发挥出其规模优势和作用。随后兴起的社区居家养老服务模式在一定程度上契合了老年人在社区“原居安养”的期望,但仍面临着服务内容单一、服务方式低效等问题。因此,面对复杂的社会形式,传统养老服务模式陷入困境,如何找到符合我国实际国情的特色养老服务模式,实现城市中老年人“老有所养”成为迫切需要解决的问题。在此背景下,社区嵌入式养老服务模式应运而生,它将上述三种传统养老服务模式进行有机融合,创新性地把专业养老机构嵌入基层,通过整合区域内养老资源,借助关系网络和信息技术,打造成集综合养老与特色医疗服务于一体的社区养老结构网络体系,为新时期缓解城市中养老资源紧缺的矛盾,满足老年人多样化的养老需求,解决社区养老问题提供了新的思路。

本文针对近年来新兴的社区嵌入式养老服务模式进行研究,以福利多元主义、嵌入性治理等理论为基础,根据社区嵌入式养老服务模式的基本要素与主要特征从嵌入式养老设施、医养结合养老服务、社区老年参与、智慧化养老体系等四个维度出发,对北京市朝阳区四个街道展开实地调研,重点聚焦北京市“十三五”以来养老政策,社区嵌入式养老服务模式建设现状及存在问题,并且结合日本、美国、上海等国内外地区的先进经验,探讨出北京市社区嵌入式养老服务模式应从促进协同发展、夯实硬件基础、落实需求导向、营造包容氛围、助力科技创新、多元筹措资金、打造专业人才等方面予以优化,为该模式在我国其他地区的推广和发展提供参考借鉴。

关键词: 人口老龄化 社区嵌入式养老 养老服务驿站 医养结合

Abstract

Since the 21st century, China has entered an aging society. The elderly population is not only large in scale and rapid growth, but also shows the characteristics of aging, disability and empty-nest. The problems in the field of elderly care service are attracting widespread attention from all walks of life. With the development of China's social economy and the transformation of family structure, the needs of the elderly are increasingly diverse, but in China's community governance, the shortage of resources such as land, capital and human resources has brought unprecedented pressure to the elderly care services. For a long time, due to the influence of Confucianism, the family elderly care service model that advocates "raising children for old age" has been deeply rooted in China. However, with the impact of declining fertility rate, family differentiation and getting old before getting rich, the care function of this model is weakening. At the same time, institutional elderly care service model generally choose to set up large-scale professional elderly care institution in the suburbs, equipped with advanced facilities for aged and plenty of medical staff, can make old people enjoy the elderly care services standardization, but it is limited by service prices, location distance, emotional barriers, social cognition, failed to give full play to its scale advantage and function. The subsequent rise of home-based elderly care service model in the community fits the expectation of the elderly in the community for "home care", to a certain extent, but it still faces problems such as single service content and inefficient service mode. Therefore, in the face of the complex social form, the traditional elderly care service model is in trouble. How to find the characteristic elderly care service model in line with China's actual national conditions and realize the "elderly support" in the city has become an urgent problem to be solved. Embedded in this background, the community-embedded elderly care service model arises at the historic moment, it organically integrates the above three kinds of traditional elderly care service model and innovatively embeds professional elderly care institutions at the grassroots level. Through the integration of community regional of elderly care resources, with the help of relationship network and information technology, make comprehensive elderly care and characteristic medical service in the integration of community-embedded elderly care structure of

network system, It provides a new idea for alleviating the contradiction of the shortage of elderly care resources in the city in the new era, meeting the diversified needs of the elderly and solving the problem of community elderly care.

Based on the theory of welfare pluralism and embedded governance, this paper studies the emerging community-embedded elderly care service models in recent years. According to the basic elements and main features of the community-embedded elderly care service model, starting from the four dimensions of the embedded facilities with elderly, combination of medical treatment and elderly care services, community elderly participation and intelligent elderly care system, Field investigations was carried out on four streets in Chaoyang District of Beijing, focusing on the elderly care policies of Beijing since the 13th Five-Year Plan, the current situation and existing problems of the construction of community-embedded elderly care service models. And combined with the advanced experience of Japan, the United States, Shanghai and other domestic and foreign regions. It is discussed that the community-embedded elderly care service model in Beijing should be optimized from the following aspects: promoting collaborative development, strengthening hardware foundation, implementing demand-oriented, creating an inclusive atmosphere, facilitating scientific and technological innovation, raising funds in multiple ways and building professional talents, which can provide reference for the promotion and development of this model in other regions of China.

Key words: population aging, community-embedded elderly care, elderly care service station, combination of medical treatment and elderly care services

目 录

第一章 绪论.....	4
第一节 选题背景与研究意义	4
第二节 核心概念界定.....	6
第三节 研究思路与研究方法	8
第四节 创新之处与不足.....	10
第二章 文献综述	11
第一节 国外相关研究.....	11
第二节 国内相关研究.....	12
第三节 国内外文献评述.....	14
第三章 社区嵌入式养老服务模式的基本情况	15
第一节 社区嵌入式养老服务模式的理论基础	15
第二节 社区嵌入式养老服务模式与其他模式区别	17
第三节 社区嵌入式养老服务模式的主要特征	18
第四章 北京市朝阳区社区嵌入式养老服务模式的调查研究	23
第一节 北京市社区嵌入式养老服务模式的政策演变	23
第二节 北京市朝阳区社区嵌入式养老服务模式的实地调研	26
第三节 北京市朝阳区社区嵌入式养老服务模式的问卷调查	31
第四节 北京市朝阳区社区嵌入式养老服务模式存在问题	37
第五章 国内外社区嵌入式养老服务模式的经验借鉴	43
第一节 日本社区照护模式.....	43
第二节 美国长期护理 PACE 模式.....	43
第三节 上海长者照护之家模式	44
第四节 国内外社区嵌入式养老服务模式发展经验启示	45
第六章 北京市优化社区嵌入式养老服务模式的对策	47
第一节 统筹部门权责和顶层设计	47
第二节 补齐社区嵌入式养老设施短板	47
第三节 全面提升医养结合养老服务水平	48
第四节 推动养老互助和志愿活动	49
第五节 助力智慧赋能养老体系建设	50
第六节 打造多元的筹资方式和专业的人才队伍	50
结论与展望.....	52
参考文献.....	54
附录一 北京市朝阳区社区嵌入式养老服务需求调查问卷	59
附录二 北京市朝阳区社区嵌入式养老服务模式建设情况访谈提纲	62

第一章 绪论

作为本文的第一章，分析了构建社区嵌入式养老服务模式的背景与意义，明晰了养老服务体系中家庭、机构、社区居家、社区嵌入式等养老服务模式的概念，点明了本文的研究思路并交待了研究方法，为下文展开做铺垫。

第一节 选题背景与研究意义

一、选题背景

我国已进入快速老龄化的发展阶段，根据第七次全国人口普查数据显示，截止到 2020 年 11 月 1 日零时，全国总人口 141178 万人，与 2010 年第六次全国人口普查时 133972 万人相比增长了 5.38%，其中 60 岁及以上人口为 26402 万人，占总人口的 18.7%，与 2010 年 60 岁及以上人口 17765 万人相比上升了 48.62%^①。面对如此复杂严峻的老龄化形势，如何养老成为当前社会一个无法回避的热点问题，必须采取积极应对人口老龄化策略，重塑养老服务体系，提高养老服务的能力，才能适应加速到来的老龄化社会。与此同时日益庞大的老年群体及不断增长的养老需求也催生出“银发经济”，使养老产业具有广阔的市场发展前景。因此，在这个充满挑战和机遇的时代，国家高度重视养老服务体系的建设，将积极应对人口老龄化上升为国家战略，习近平总书记在党的十九大报告中提出：“积极应对老龄化，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，推进医养结合，加快老龄事业和产业发展。”这为新时期探索建设具有中国特色的养老服务模式指明了新的方向。

北京市作为我国的首都，无论是老年人口数量还是老龄化程度都位居全国前列。根据第七次全国人口普查数据显示，截止到 2020 年 11 月 1 日零时，北京市常住人口 2189.3 万人，其中 60 岁及以上人口为 429.9 万人，占北京市总人口的 19.6%，即将突破联合国确定的 20% “中度老龄化”下限^②。除此之外，北京市老年人口还呈现出增长速度快、高龄比重大、空巢家庭多等突出特点。在北京市疏解非首都功能，推动京津冀协同发展的战略大背景下，日渐沉重的养老负担对首都社会经济与城市治理都产生了广泛而深刻的影响，迫切需要加快建立

^① 国家统计局官网. 第七次全国人口普查公报(第五号)[EB/OL]. http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/rkpcgb/qgrkpcgb/202106/t20210628_1818824.html. 发布时间 2021 年 5 月 11 日.

^② 北京市人民政府官网. 北京市第七次全国人口普查公报(第三号)[EB/OL]. http://www.beijing.gov.cn/gongkai/shuju/sjjd/202105/t20210519_2392888.html. 发布时间 2021 年 5 月 19 日.

与之相适应的养老服务体系。为此，作为我国养老服务体系改革的先驱，北京市依托于国家加速发展养老事业，密集出台养老政策的大环境，早在 2009 年就下发了《关于加快养老服务机构发展的意见》，明确提出北京市养老服务坚持以“全面关怀，重点照顾”为理念，努力打造“9064”养老服务新模式。通过加大社区养老设施规划、投资、建设，逐步建立以“大型机构为引领、中型机构为主体、小型机构为补充”的养老网络布局，使社区养老服务由补缺型向普惠型转变。

朝阳区作为北京市六大主城区中面积最大，人口最多的地区，老年人口基数排在全市第一。根据第七次全国人口普查数据显示，截止到 2020 年 11 月 1 日零时，北京市朝阳区全区常住人口为 345.2 万人，与 2010 年第六次全国人口普查的 354.5 万人相比，减少约 9.3 万人，下降 2.6%；60 岁及以上人口为 70.9 万人，占 20.5%，与 2010 年相比 60 岁及以上人口的比重上升 8.3 个百分点，人口老龄化程度远高于全国及北京市水平^①。再加上辖区内 43 个街乡之间的地区差异明显，给养老工作的精细化、标准化管理带来了严峻的挑战。为应对已经到来的人口老龄化浪潮，朝阳区在 2013 年开始社会化养老服务体系的建设，结合全国养老服务社会示范区、养老服务综合改革试点区以及老年友好型社区示范点等创建工作，探索出“1+43+N”的“三边四级”养老服务体系，创新性通过将微型专业养老机构嵌入社区，形成医养结合养老服务供给网络，建立起街乡之间资源互换和经济补偿机制，把养老服务直接送到老人的“周边、身边、床边”，逐步形成“居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合、覆盖城乡”的社区嵌入式养老服务新模式。

从全国、北京市到朝阳区的人口老龄化现状及养老服务体系发展来看，现阶段各种养老服务模式正逐渐走向融合，但其在协同发展过程中仍存在或多或少的局限，难以满足老年人多样化的养老新需求。社区嵌入式养老服务模式创新性弥补了家庭、机构和社区居家等养老服务模式之间的结构性矛盾，一方面与既有养老服务模式相比，具有规模小、多功能、专业化等优势，另一方面，满足了老年人“原居安养”的愿望，增加老年人对社区的归属感和幸福感。因此，在结合国内外已有经验的基础上，系统性地研究北京市社区嵌入式养老服务模式，提出优化建议，有利于实现国家“老有所养、老有所依、老有所乐、老有所为”的积极应对人口老龄化战略目标。

二、研究意义

^① 北京朝阳官方发布. 北京市朝阳区第七次全国人口普查公报[EB/OL]. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1702165333860743053&wfr=spider&for=pc>. 发布时间 2021 年 6 月 10 日.

（一）理论意义

由于我国社区嵌入式养老服务模式尚处于起步阶段，研究文献较少，且多集中在理论研究、模式比较、经验介绍等方面，本文笔者深入基层从街道层面对北京市朝阳区社区嵌入式养老服务模式进行调研，以调查研究提升福利多元主义、嵌入性治理等理论指导价值，充实该领域现有的养老研究成果，为其他同样陷入养老服务发展困境的地区提出新的思路。

（二）现实意义

养老作为当前社会民生领域的热点与难点话题，一直备受各界关注。针对社区嵌入式养老服务模式研究在一定程度上打破既有养老服务模式的局限，有助于将养老资源进行有效整合，优化养老服务供给路径，满足多样化养老服务需求，进一步提高社区养老服务能力和水平，构建更加适合我国国情的养老服务体系。同时从当前我国社区嵌入式养老服务模式试点地区的具体实践来看，各地政策经验呈现碎片化、零散化，无法起到推广、复制作用。本文通过对朝阳区社区嵌入式养老服务模式的实践调研，提出切合实际的对策建议，总结北京市社区养老领域的成功经验，为各地制定具体的养老政策提供参考。

第二节 核心概念界定

一、家庭养老

家庭养老，顾名思义，主要是基于婚姻或血缘关系由配偶、子女及亲戚等家庭成员来赡养老年人，负责老年人生活照料和情感陪伴的一种传统养老服务模式。由于我国自古以来推崇儒家尊老爱幼的孝道伦理，重视家庭的亲情羁绊，因此家庭养老具有悠久的历史文化根源，在改革开放前的很长时期内处于主导地位，但随着社会变迁以及人们工作生活节奏加快，家庭规模逐渐缩小，家庭结构开始分化，家庭婚育观念也随之悄然转变，完全依靠家庭纽带维系的养老服务模式正不断削弱，急需发展社会化养老服务加以补充。

二、机构养老

机构养老主要是指由具有固定场所和专职护理人员的专业养老机构提供养老照顾，老年人的衣、食、住、行、医等都由养老机构通过市场化运作统一负责的养老服务模式。养老机构作为整个机构养老服务模式的基础，主要包括：养老院、敬老院、老年公寓、托老所、老年护理站等形式，采用连锁化经营，有利于节约社会养老成本，实现养老资源的高效利用，曾一度成为欧美等发达国家的主

流养老服务模式，但对于我国而言，由于城市土地资源稀缺，大型养老机构往往建在郊区，远离老年人的原住地，造成日常出行困难，子女探视不便，再加上老年人往往具有“落叶归根”的传统情节，难以融入新的环境，对入住养老机构产生抵触情绪，因此，在机构养老服务模式下，养老机构常面临入住率不高的困境。

三、社区居家养老

社区居家养老是以社区为依托，综合运用社区内各种资源，让老年人不用离开社区就能享受便利的餐饮、家政、娱乐、健身等基础性服务的养老模式。老年人居家安享晚年，既可以缓解家庭成员照料老年人的沉重负担，给予家人喘息时间和机会，又避免了老年人居住在养老机构产生的亲情缺失问题。但该模式在养老服务专业性方面的建设并不完善，同时随着我国生活水平提高，老年人寿命逐渐延长，对医疗护理、助浴助行、心理咨询等方面的养老需求日益增多，社区居家养老的弊端开始显现。例如，大多数的社区居家养老仅提供助餐助洁等简单的家政养老服务，服务内容单一，服务形式零散，服务观念落后，难以适应老年人多样化的养老服务需求。此外，该模式主要采用政府购买服务形式进行兜底，巨大的财政压力致使社区养老服务的持续供给难以保障。

四、社区嵌入式养老

社区嵌入式养老是在家庭、机构、社区居家等养老服务模式基础上融合发展起来的新兴养老服务模式（如下图 1-1 所示）。在传统养老服务模式下，家庭养老社会化不足，缺乏专业性养老知识和技能；机构养老过度市场化，难以满足老年人居家养老的情感需要；社区居家养老的服务内容单一，专业性大打折扣，主动上门服务意识不强，造成养老服务供需不平衡矛盾突出；而社区嵌入式养老通过整合养老资源嵌入社区，最大限度地提升养老服务效率和质量，既保留了家庭养老的传统，又能实现机构养老和社区居家养老的互补双赢。对于社区嵌入式养老的概念，上海与天津结合实践给出了明确界定，其中，上海市在社区嵌入式养老服务工作指引（2019）中对其定义为：“在社区内围绕老年人生活照料、康复护理、精神慰藉等基本需求，嵌入相应的功能性设施、适配性服务和情感性支持，让处于深度老龄化的社区具备持续照料能力，让老年人在熟悉的环境中、在亲情的陪伴下养老。”天津市在社区嵌入式养老服务机构发展指导意见中指出：“社区嵌入式养老是充分依托社区养老服务设施等资源，主要为社区内和周边有需要的老年人提供专业护理、生活照料、心理慰藉、居家入户等综合性养老服务方式。”因此，本文将社区嵌入式养老定义为：立足于社区，以嵌入社区养老机

构为载体，根据老年人物质基础和精神文化需求，持续提供功能设施、多样服务和情感支持，从而使养老与社区有机融合，实现社区老年友好的一种养老服务模式。

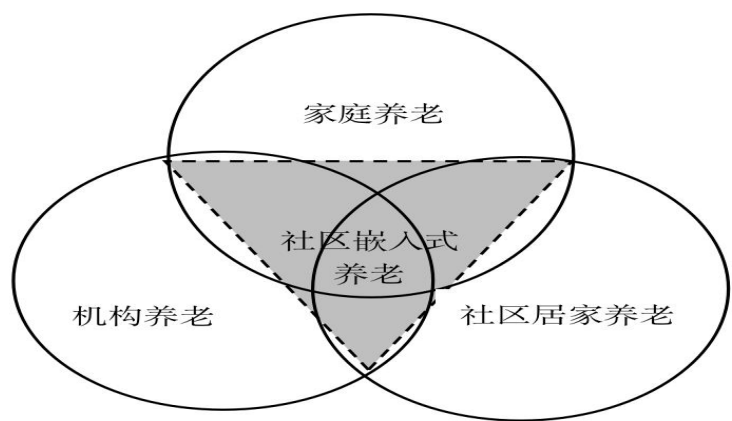


图 1-1 社区嵌入式养老服务模式图

第三节 研究思路与研究方法

一、研究思路

第一章：绪论部分介绍了本文的选题背景、研究意义、研究思路、研究方法，对本文涉及到的家庭养老、机构养老、社区居家养老、社区嵌入式养老等核心概念进行解释，进一步明晰研究对象和研究问题。

第二章：梳理国外社区照顾，国内社区嵌入式养老服务模式等文献资料，阐述国内外社区嵌入式养老服务模式的主要研究内容和发展方向。

第三章：引入福利多元主义、嵌入性治理等为本文提供理论支持，梳理社区嵌入式养老服务模式的基本要素和主要特征，结合北京市“十三五”以来出台的养老政策，设计访谈提纲和调查问卷，为开展实地调研奠定基础。

第四章：选择北京市朝阳区老龄化较严重的四个街道，深入基层进行走访座谈，收集调查问卷，重点从嵌入式养老设施、医养结合养老服务、社区老年参与、智慧化养老体系等方面摸清北京市社区嵌入式养老服务模式的实际运行现状，挖掘存在的问题。

第五章：介绍国内外社区嵌入式养老服务模式实践案例，通过对国际的日本社区照护模式、美国长期护理 PACE 模式以及国内的上海长者照护之家模式进行总结提炼，从中得出推广该模式的共性特征和发展启示。

第六章：针对当前北京市社区嵌入式养老服务模式存在问题，结合国内外地区实践经验，提出契合北京市实际的优化对策。

本论文的具体研究路线如图 1-2 所示：

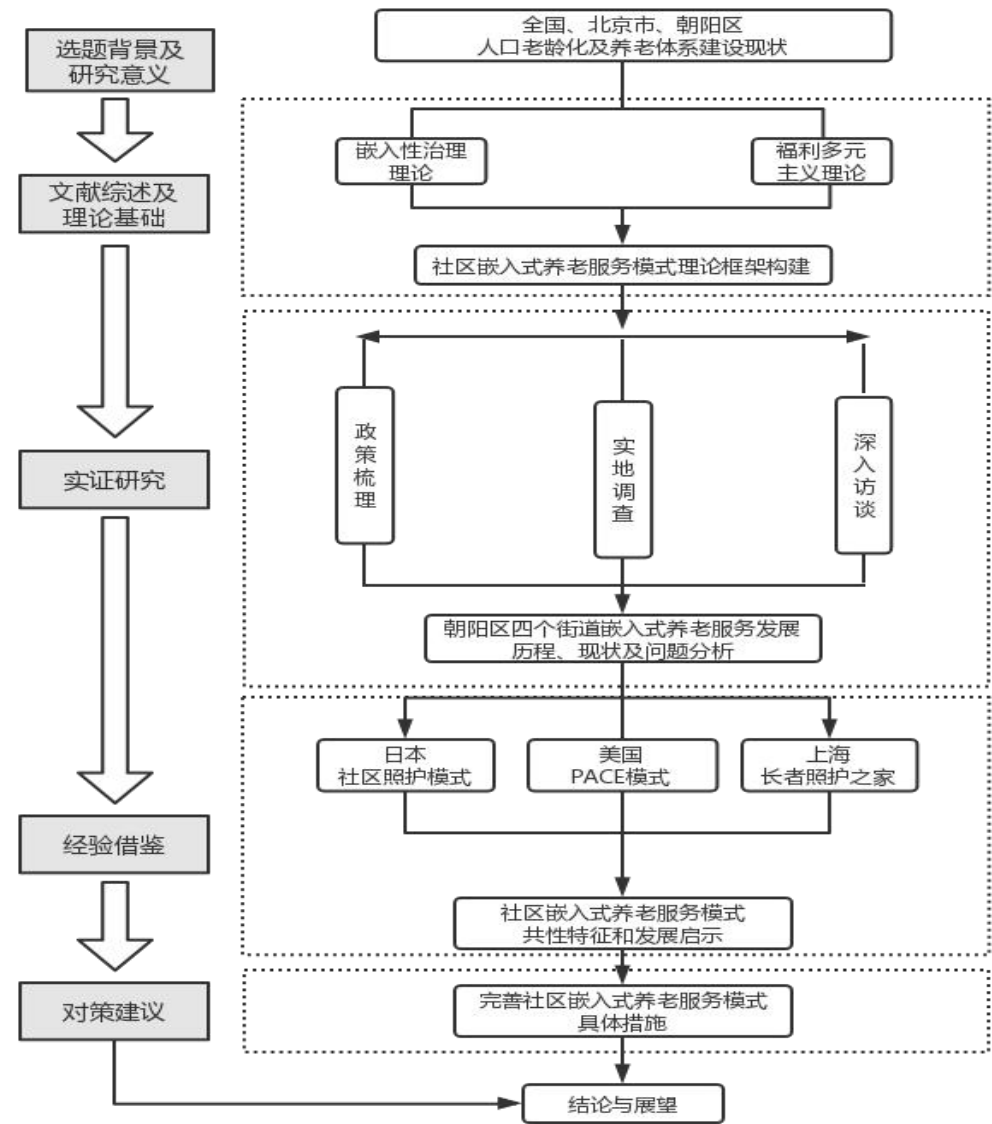


图 1-2 本文研究路线图

二、研究方法

本文利用全国创建老年友好型社区的契机，以北京市朝阳区为样本，深入老龄化严重的街道进行实地调研，从嵌入性治理视角剖析社区嵌入式养老服务模式的特征、政策、现状、问题等，并且结合国内外地区先进的实践经验，研究优化北京市社区嵌入式养老服务模式的对策建议，为达成上述研究目的，本文将采用文本分析、实地调研和比较分析相结合的研究方法。

（一）文本分析法

阅读国内外社区嵌入式养老服务模式的相关文献资料，访问国务院、北京市、朝阳区等政府部门官方网站，为本文写作收集素材。在梳理汇总各类材料的基础上得出研究的理论框架，社区嵌入式养老服务模式的优势和主要特征，为后续的实地调研奠定基础。

（二）实地调研法

本文选取了北京市朝阳区四个人口老龄化较严重的街道作为研究样本，进行了2次市区级别的政府座谈、4次街道级别的社区座谈，采用无记名方式发放300份老年人调查问卷，从嵌入式养老设施、医养结合养老服务、社区老年参与、智慧化养老体系等纬度收集数据，作为本文写作的一手材料。

（三）案例分析法

在识别出北京市社区嵌入式养老服务模式存在问题的基础上，运用案例分析方法有针对性地选取日本、美国、上海等国内外发达国家地区的成功实践经验，结合北京市社区养老短板，制定改进措施，为今后全国推广社区嵌入式养老服务模式提供借鉴。

第四节 创新之处与不足

一、本文的创新之处

社区照顾理念经过国外实践已被证实对养老具有较大的优势和潜力，但社区养老在我国仍处于起步阶段，目前学术界对该领域的研究相对较少。本文围绕嵌入视角对社区养老进行研究，在一定程度上丰富了现有的研究成果，具有创新意义。同时根据当前对社区嵌入式养老服务模式的研究文献，发现主要集中在理论研究、模式比较及经验借鉴方面，少有针对该模式的政策法规梳理和实地调查研究。本文对北京市社区嵌入式养老服务政策进行梳理并深入朝阳区开展实地走访，采用理论联系实际形式，为该模式的充实完善提供有益参考。

二、本文的不足之处

本文主要聚焦在北京市社区嵌入式养老服务模式研究，尽管在撰写论文过程中参考了外地的实践经验，也查阅了众多文献，但由于本人研究经验不足以及相关专业知识的欠缺，调查分析过程中具有一定的局限性，在研究的普适性和深刻程度上仍需进一步提高。

第二章 文献综述

围绕本文的研究主题，在当前全球人口老龄化的趋势下，国内外学者对于社区养老领域的研究都很重视，集中涌现出大量的研究成果，在此本章梳理了国外社区照顾以及国内社区嵌入式养老服务模式等文献，经过归纳分析，对相关研究领域的发展历程、研究现状、未来方向有了较为全面的了解。

第一节 国外相关研究

从国外养老领域的研究来看，未出现嵌入式养老等专有名词，但他们强调社区照顾理念，将专业的医护服务引入社区，让老年人在熟悉的环境中安享晚年，这与社区嵌入式养老服务模式一脉相承。早在 20 世纪初，西方发达国家就已陆续迈入老龄化社会，在养老模式改革、养老服务供给、养老产业市场化等方面都积累了成熟的经验，主要形成了以瑞典、挪威、芬兰等北欧国家为代表的高福利机制型养老服务体系，以美国、英国为代表的市场化运作补缺型养老服务体系，以日本为代表的政府主导福利型养老服务体系。这些养老体系的共同特点是具有高度专业化的养老服务机构提供丰富完善的养老服务。但 20 世纪 50 年代以来，随着民众“去机构化”和回归家庭的呼声日益高涨，一些发达国家调整机构养老服务发展战略，让老年人回归自己熟悉的家庭和社区。社区照顾的逐渐兴起促使养老服务模式悄然发生转变，于是各国学者开始调整方向，更加侧重于社区的养老照顾方式、养老管理效率、养老服务质量等方面研究，这为社区嵌入式养老服务模式的产生奠定基础。其中，Sharfstein (1974) 在对医院住院照顾和社区医疗照顾的两组慢性病老年人治疗的效果和花费的费用进行比较后，发现社区医疗照顾成本更低，老年人身体恢复更好。随后 Newcomer (1997)、Boulton (2000) 等纷纷通过个案研究，显示出社区照顾具有较高的养老管理效率，而且会降低社区老年人慢性疾病的患病率，这让社区照顾逐渐进入大众视角。Evashwick (1996) 在《长期持续性照顾》一文中主张要建立一个持续性照顾老年人的网络，该网络应包含居家照顾、社区照顾和机构照顾，并且通过综合各种照顾的优势来加快养老资源整合，明确提出了将各项养老照顾方式融合发展的新思路。20 世纪 80 年代后，社区照顾模式已成为国外养老的主流，此时如何提高社区养老管理效率成为其关注的重点。Challis (1985) 针对英国的社区照顾计划进行研究，引入老年人的养老需求评估机制，有针对性的提供养老服务来提高

管理的效率并形成一套系统的服务流程；Griffiths（1988）提出了“照料管理”的理念，其核心是通过与老年人沟通来设计“社区照料服务包”，制定菜单式养老服务来提高社区照顾的效率。而不同于Challis与Griffiths从老年人需求的角度研究社区养老管理效率问题，Hillel（2004）、Cott（2008）提出多元主体参与的管理体制，建议强化协调合作，整合政府、市场、企业、居民等主体的力量，提高社区养老管理效率。之后随着社会经济发展和收入水平提高，社区养老服务不再仅停留在效率层面，也更关注服务的质量。Sherry Anne Chapman（2002）认为社区养老不仅可以提升养老资源使用效率，通过精神慰藉、情感陪伴等养老方式，也会增强老年人的社区归属感，促进社会的进步。由此可见，经过国外学者研究，社区养老与传统的养老相比具有更高的效率和更好的效果。因此，从社区照顾理念的不同角度去研究社会化养老的问题，促使国外养老服务由机构回归社区，由政府直接供给过渡到社会各方参与，已经形成了相对完善的社区照顾养老体系，这对我国社区嵌入式养老服务模式研究有较大的借鉴意义。

第二节 国内相关研究

国内学者对我国社区嵌入式养老服务模式已进行了较多的研究探索。截止到2020年12月底，在中国知网上以“嵌入式养老”为主题检索，涉及文献共有232篇，从已有文献来看，主要集中在社区嵌入式养老服务模式的核心概念界定、国外经验介绍、国内实践研究、问题对策分析等几个方面。

关于核心概念的界定，国内学者总体而言主要从管理学和社会学等视角进行阐述，例如：胡宏伟等（2015）通过各种养老服务模式对比归纳出社区嵌入式养老服务模式概念，即基于资源、功能、运作方式等嵌入为理念，以社区为载体，引入市场化竞争机制，提供专业服务的养老方式。赵小兰、孟艳春（2015）结合社区嵌入式养老服务模式的优势指出其实质是一种融合性的社区养老服务解决方案，把社会化养老机构嵌入到社区闲置公共空间，为不同类型的老年人提供个性化养老服务，有效缓解家庭成员的养老压力，搭建起家庭、机构、社区居家等养老服务模式的桥梁和纽带。而闫小红（2020）从社会资本理论角度出发，认为社区嵌入式养老服务模式是通过向社区嵌入设施、服务和情感，来有效整合社区资源，实现社区网络和信任关系构建过程。

由于国外发达国家进入老龄化社会较早，在养老实践方面已积累了丰富的经验。因此，如何将国外成熟的社区照顾理念引入中国，更好的与我国实际相结合

自然成为国内学者关心的问题，例如：穆光宗（2012）通过回顾美国社区居家养老的发展历程，系统性介绍美国社区养老的四种类型以及养老照料机构“居家养老院”的基本情况，特别强调近年来在美国兴起的长期护理 PACE 模式，其社区养老与医护团队一体化的发展思路，为我国社区开展医养结合养老服务提供了很好的借鉴。康越（2017）从日本国内社区嵌入式养老发展历程及其经验出发，归纳出日本社区照护式养老模式特点，在养老政策理念，养老设施品质，养老服务细节等方面就如何进一步提升我国社区嵌入式养老服务模式的人性化水平给出了许多建设性意见。钟慧澜、章晓懿（2016）从养老服务市场化改革角度对瑞典、英国、澳大利亚的养老模式特点和共同面临问题进行对比分析，认为“去机构化”与“非正式照护”相互配合是社区养老服务可持续发展的关键，要求嵌入社区的养老机构应采用市场化运作模式，建立起养老需求评估和养老服务清单制度，让社区养老责任在政府、企业、社会、家庭之间合理分配，这对我国建立政府主导，多元参与的养老服务供给机制提供了参考价值。

与国外相类似，随着国内上海、北京、天津等地开展养老服务体系改革试点，各地经过多年实践已探索出各具特色的社区养老道路。因此，国内学者纷纷将目光由国外转向国内，聚焦社区养老的本土化创新发展。其中，陈醉（2020）、郝勇、骆潇蔓（2021）、陈岩等（2021）等以上海市的“长者照护之家”为研究对象，从养老政策发展历程、嵌入式养老机构设置、养老服务供给情况等不同方面深入探讨，形成小规模、专业化和多功能于一体的社区嵌入式养老服务“上海方案”。周悦、崔炜（2019）通过对北京市养老服务驿站的调查研究，详细论述了 2017 年以来，北京市不同类型的养老服务驿站发展概况、存在障碍以及发展建议，主张优化养老服务驿站的养老服务功能，凸显其在构建北京市“三边四级”社区嵌入式养老服务网络中的价值。徐旭等（2018）通过对天津市 400 多名老年人的养老需求调查分析，以人本主义需要理论建立嵌入式养护中心网络，建议从转变养老服务观念，构建网络化服务框架，完善医养结合，推动服务人才队伍建设等方面优化社区嵌入式养老服务建设路径。

由国内外地区的实践研究可以看出无论采用何种养老服务模式，只有结合自身实际进行持续的改革创新才能使养老服务体系发展得更成熟完善。特别是我国正处于社会经济发展与人口结构转型双重叠加的关键期，对社区嵌入式养老服务模式的探索不仅可以缓解城市土地资源紧张局面，实现社区养老设施整合共享，养老服务优化升级（宋晓宇，2020），具有非常重要的现实意义，而且也体现

出满足老年人“原居安养”的养老理念和弘扬中华民族敬老美德的人文意义（朱勤浩，2017）。但与此同时，部分学者在上述研究中也发现该模式仍存在许多不足，例如：传统养老观念阻碍、政府规划与政策落实滞后、社区管理与企业运营脱节（胡宏伟等，2015）、养老机构运营成本高、投资回收期长、养老服务功能定位模糊（郭晓敏，2018）、社区邻避效应阻力较大、养老融资渠道狭窄、专业护理人才严重缺失（安炳辉，2020）等，导致社区嵌入式养老服务模式发展陷入困境。对此不少国内学者都结合当地实际从不同角度对建设具有中国本土特色的社区嵌入式养老服务模式给出了有益建议：章萍（2016）依据上海“长者照护之家”试点运行情况，认为应建立有效的市场机制、老年护理保险制度和养老服务志愿者激励机制，同时从政策制度层面改善养老服务市场供需关系；王晶、李鹏飞（2019）基于上海地区和欠发达省份养老服务现状的考察，主要从养老政策制定、适老化设施配置、养老服务形式与内容、养老机构运行机制等方面进行比较分析，提出应加强政府部门协作、完善财政资金补贴制度、健全服务运营机制、推进服务队伍建设、加大对养老机构评估监管，因地制宜发展养老服务事业；张仁枫、苑港华（2020）经过系统性梳理2012年到2020年社区嵌入式养老研究文献，对研究作者、研究热点、研究问题、研究趋势进行综述，认为应加大宣传力度注重养老服务供给主体参与、营造良好的市场竞争环境以吸引社会资本进入、提高医养结合程度和培养专业养老人才、科学合理指导养老设施规划设计等，为今后我国社区嵌入式养老服务模式发展作出新的指引。

第三节 国内外文献评述

综上所述，社区嵌入式养老服务模式是以国外社区照顾理念结合我国的具体国情提出新兴模式，虽然学术界对于社区嵌入式养老服务模式的概念有不同的认识，研究的内容也各有侧重，但基本上都认可该模式能充分调动养老服务供给主体参与，最大限度地整合社区养老资源，提供更具专业性和人性化养老服务，更好地满足老年人多样化的养老需求，已成为未来养老服务改革发展研究的重点及方向。但由于目前我国社区嵌入式养老服务模式发展仍处于起步阶段，国内的学术界研究比较宽泛，深入基层从嵌入性治理视角进行调查研究的案例较少。因此，本文将对北京市朝阳区四个街道的社区嵌入式养老服务模式建设现状进行实地调研，梳理其中存在的问题，在此基础上提出优化对策，为推动该模式在我国的进一步发展提供参考。

第三章 社区嵌入式养老服务模式的基本情况

经过前两章对社区嵌入式养老服务模式的概念和当前国内外研究成果的概述，让我们对社区嵌入式养老服务模式有了初步了解。但在进行实地调研前，需要进一步剖析社区嵌入式养老服务模式包含的具体内容，本章从该模式理论基础、优势区别、主要特征等方面展开分析，为设计访谈提纲和调查问卷做准备。

第一节 社区嵌入式养老服务模式的理论基础

一、福利多元主义理论

福利多元主义的概念源自英国 Wolfenden (1978) 的《志愿组织的未来报告》，报告指出福利供给存在着多元供给主体，而志愿组织也是其中之一，就此拉开了对福利多元主义理论的研究序幕。Rose (1986) 经过梳理英美等国家养老福利体系发展史，认为一个社会的福利供给来源于国家、市场、家庭等三个部门并由这三个部门多元组合产生。随后，Evers (1990) 在 Rose 分析框架的基础上提出了“福利三角”研究范式：建立以组织、价值和社会成员三个维度来分析国家、市场、家庭的理论架构。Johnson (1999) 则对福利三角进一步延伸，将 Wolfenden 提出的志愿组织加入，形成国家、市场、家庭、志愿组织联合作用的福利四分法。福利多元主义理论从诞生以来就一直秉承福利供给主体多元化，福利来源多渠道，其核心理念是将政府福利供给的部分领域和职责让渡给其他主体，使企业、家庭、志愿组织等非政府主体也可以参与到社会福利的供给和决策中来。因此，在发展社会福利时首先要明确各主体之间的职责，例如：政府将福利供给的大部分权利合理分配给其他主体，更多的是充当政策制定者、秩序规范者和矛盾仲裁者；企业作为福利供给的主要参与者，通过市场化的运作降低供给成本，提高供给效率，实现福利资源的优化配置；社会中非营利组织则可以拓宽福利供给渠道，丰富福利供给内容形式，形成公平有效的市场竞争环境；家庭和个人在福利供给和监督方面也发挥着重要作用。然后再通过政府、企业、社会、家庭甚至是个人的共同参与来形成福利供给主体多元化。由此可见，在福利多元主义理论的框架下，社区养老服务的供给不仅仅是政府或家庭的单方面的行为，应该在“以老年人需求为中心”的前提下，吸引企业、社会、家庭、个人等其他主体加入，明确各主体在社区养老中的职责，形成“政府主导，多元参与”的养老服务协同发展

新格局。

二、嵌入性治理理论

“嵌入”本义指将有价值的东西嵌入原有载体，使其具有新的生命力和价值的积极活动。嵌入一词最早由匈牙利经济学家 Karl.Polanyi (1944) 引入经济学研究领域，他发现经济行为与社会制度之间存在相互依存关系，将这种关系的形成过程称之为“嵌入性”，并指出市场经济活动应嵌入到社会关系网络之中。随后嵌入性作为一种治理范式拓展到社会学领域并开始得到人们普遍关注。例如：美国社会学家 Mark.Granovetter (1985) 将社会资本和嵌入治理理论有机融合，认为社会中的个体不是孤立存在的，而是嵌入在特定的社会结构和社会关系网络中，通过依附的社会关系网络交换联系从而获得信息、情感、服务等方面的资源以及相应的社会支持。此后，Mark 又进一步将其细化，分为结构嵌入和关系嵌入，构建起嵌入性治理的理论分析框架。其中，结构嵌入主要研究社会主体在形成整体网络过程中的发展定位和特有功能，关系嵌入则描述社会主体嵌入特定的网络之中，以互惠预期和信任机制为纽带而发生的双向关系，这为嵌入性治理引入养老领域奠定了理论基础。在嵌入性治理视角下，要使养老服务模式下沉至社区甚至是家庭，在多元主体结构下必须依靠各方的合作，通过社区养老资源的科学配置，医疗护理与养老服务的有效衔接，信息技术的更新升级，实现对老年人养老需求满足和精神情感支持，搭建起养老设施网络、养老服务网络、信息技术网络。同时利用社区现有网络开展各种老年活动，增进各方与老年人之间相互交流，形成社区中相对稳定的关系网络和信任机制，推动老年人互助力量的培育，可以为社区嵌入式养老服务模式发展提供持续动力。可以说，社区嵌入式养老意味着主体在互动合作过程中通过资源、功能、关系、技术的利用产生嵌入性，形成紧密牢固的嵌入式结构类型网络。各类主体之间彼此互相羁绊，各种层级网络之间又互相连接，建立起多层次的社区养老结构网络体系，使得养老资源重组，养老服务社会化运作，社区信任关系重塑，促进养老服务模式与社区融为一体。

综上所述，福利多元主义与嵌入性治理理论在促进养老服务模式融合发展方面存在紧密联系。要构建完善的养老服务体系，尤其是解决社区老年群体养老照护的刚性需求、解放家庭成员照料压力、激活养老市场竞争机制、统筹并有效利用养老资源，不仅需要政府、企业、社会、家庭以及个人等主体充分参与，更要对各类主体的职责及其相互关系进行重新定位，在此基础上，通过资源嵌入、功能整合、情感依托、信息技术等多渠道合作，建立起多层次的社区养老结构网络

体系，实现家庭、机构和社区居家等养老服务模式的融合协同发展。

第二节 社区嵌入式养老服务模式与其他模式区别

社区嵌入式养老服务模式的出现，折射出我国养老服务体系的转型和升级。它不只是将家庭、机构、社区居家等传统养老服务模式的简单叠加，而是通过吸收原有模式的优点并建立起彼此之间联系，在此基础上不断优化迭代形成一种更具人性化的养老服务模式，具体内容如表 3-1 所示：

表 3-1 四大养老服务模式对比

类型	家庭养老	机构养老	社区居家养老	社区嵌入式养老
服务供给主体	家庭参与	企业参与	政府为主，社会与企业为辅	政府主导、企业、社会、家庭、个人等多元主体共同参与
服务内容和方式	照料、陪伴等基础性居家照顾方式	助餐、照料、助医等专业性养老服务，服务方式多采取长期全托入住形式	助餐、照料、家政等常规基础类服务，服务方式以社区驻点为主，兼顾上门服务	助餐、助浴、助行、助医、照料、家政、代购、维权、慰藉等医养结合养老服务。服务方式采取日托、短住和访问相结合；线下和线上相结合
服务对象范围	自家老年人	机构老年人	社区老年人	以特困低保、高龄、失能、残障等特殊老年人为重点，覆盖社区及周边全体老年人
建设运营模式	无	分为政府投资的公立养老机构与私人投资的民营养老机构，采用市场化运作模式	主要为政府或企业出资投资建设，政府财政补贴运营	采取公建民营、民建民营、联合运营等多种模式，充分利用社会力量

资料来源：作者根据相关文献整理

服务供给主体更多元。传统养老模式仅依靠政府、企业、社会、家庭等单一力量，容易导致养老服务效率不高。社区嵌入式养老服务模式打破过去养老服务模式中各类主体彼此孤立状态，将各方充分调动起来，提高合作效率，形成政府主导、多元参与的养老服务供给新格局，保障社区养老服务稳定发展。

服务内容和方式更多样。社区嵌入式养老服务模式在服务内容上最大的变化在于医疗服务的加入。依托养老设施和医疗机构整合，配置专业医护团队，使社区养老服务内容从基础的生活照料、家政保洁向医养结合的方向扩展，衍生出医疗护理、康宁保健、法律维权、心理慰藉等特色服务，使服务内容更充实；同时

服务方式也更具弹性，采用日间托养、短期入住与上门服务相结合，线下与线上相结合，满足社区老年人多样化养老需求，实现社区养老服务提质增效。

服务的对象范围更精准。基于地缘优势的社区嵌入式养老服务模式，将老年人划分为自理、半自理、不能自理等类型，有针对性地采取不同的措施，不仅可以扩大服务覆盖面，而且在服务的人群上也更加细化。例如：对于半自理等行动不便老年人提供上门巡诊和驻家医生等个性化的定制服务，使其足不出户就能享受专业的医养服务；对于能够自理的健康老年人可以白天到社区微型便民养老机构享受日托服务，夜间回家住宿，满足居家养老的愿望；对于高龄、失能、残障等不能自理以及术后康复的特殊老年群体，可以在社区微型便民养老机构内享受短期寄住服务，通过康复护理和生活照料让其尽快恢复自理能力。

建设运营模式更灵活。由于养老服务属于准公益产品，传统养老服务模式单纯依靠政府或企业很难持续承担庞大的养老成本费用，而社区嵌入式养老服务模式由于嵌入的养老机构规模小，门槛低，可以因地制宜地灵活选择公办民营、民办民营、联合运营等方式，有效地减少投资风险，实现经济效益和社会效益的平衡。

由此可见，社区嵌入式养老服务模式“麻雀虽小，五脏俱全”，是在家庭、机构、社区居家等养老服务模式基础上的继承和延展，具有诸多优势，有利于缓解社区养老资源短缺的问题，解决社区养老服务供需不平衡的矛盾，满足不同老年人多样化养老需求，实现社区养老机构微利可持续的建设运营，因此值得大力提倡和推广。

第三节 社区嵌入式养老服务模式的主要特征

社区嵌入式养老服务模式核心理念在于让老年人“原居安养”，要真正实现“原居安养”，社区则必须有就近可达的养老设施，有精准可及的养老服务，有丰富多彩的老年参与活动，有便利快捷的信息技术支持。因此，社区嵌入式养老服务模式的关键在于“嵌入性”，将资源、功能、关系、技术等特征要素嵌入社区，形成各种嵌入结构网络，使得养老服务与社区紧密融合，让社区具备持续照料老年人的能力，从而使老年人在熟悉的环境中享受到就地安养的乐趣。主要表现在以下四个方面：

一、资源嵌入，挖掘丰富多样的嵌入式养老设施

众所周知，城市核心区域寸金寸土，可挖潜的空间、资源有限，难以支撑传

统大型养老机构建设，而设立在郊区的养老机构由于距离、费用、观念等问题导致老年人入住率不高。社区嵌入式养老服务模式很好地弥补了上述不足，它不仅仅是简单地将养老与医疗机构搬进社区，更要求嵌入的资源与社区原生系统产生“有机”联系，通过盘活社区公共空间，整合社区周边养老配套，改造社区内公共基础设施，形成完善的嵌入式养老设施网络，使老年人在社区熟悉的环境中就能享受专业便捷的医疗养老服务，为家人就近探视、老年人就近养老创造良好的环境和条件。主要包括：

（一）便民微型养老机构。例如：养老指导中心、养老照料中心、养老服务驿站、卫生服务中心、医疗护理站以及其附属的老年食堂等，将专业养老、医疗等机构压缩规模后嵌入社区，设立日间托养和短期入住床位，充分发挥其“短托长住”的优势，为家庭照护成员提供喘息机会，体现出机构养老家庭化，家庭照护专业化的趋势特征，既能缓解城市养老用地紧张的矛盾，又满足了老年人“原居安养”的愿望，有利于实现养老资源共享。

（二）社区周边养老配套设施。例如：老年公寓、养老院、敬老院、综合医院、老年大学、便利店以及公共服务商等。资源嵌入不能仅从专业的机构层面考虑，既然要扎根社区，就必须充分利用社区周边养老配套资源，通过战略协议、签约合作等形式组成综合医养联合体，克服配套设施碎片化，实现社区养老资源优势互补，进一步健全养老设施网络。

（三）社区内公共基础设施。例如：住宅内的扶手、自动感应门、烟雾报警器、防滑地面砖；公共区域中的电梯、座椅、无障碍厕所及坡道、人行天桥、地下通道、消防安全设施、道路照明指示设施等。依托社区原有基础设施进行适老化及无障碍升级改造，使其与社区环境融为一体，为老年人居住、出行、娱乐提供最大便利。

二、功能嵌入，提供精准定位老年人需求的医养结合养老服务

我国社会经济的快速发展，老年人收入水平和生活质量不断提高，对养老服务需求量日益扩大，同时伴随着老年人年龄的增长，各种慢性疾病渐渐出现，医疗服务成为其生活必需之一。然而过去我国养老领域的医疗水平不高，医疗领域对养老服务的支持能力也十分有限。究其原因，主要还是医疗与养老之间存在着资源壁垒，无法实现双方的有机结合。如今社区嵌入式养老设施的资源整合集聚引发养老服务功能变革，为开展多类型的养老服务创造有利条件。具体而言，一方面，让辖区内的养老机构与医疗机构相互合作，建立医养结合综合联盟，提供

生活照料、医疗护理、互助关爱等多功能的服务，实现养老服务内容和种类的升级；另一方面，通过在社区内嵌入式养老机构设立医护站点，派驻医护人员，让医养结合养老服务可以由社区延伸进家庭，扩大养老服务的辐射范围，实现养老服务方式的转变。医养结合养老服务功能嵌入从源头上打通了医疗与养老之间的壁垒，使得养老领域增强医疗能力，医疗领域提升对养老服务支持，有利于构建完善的养老服务网络，精准满足社区老年人多样化的养老需求。主要包括：

（一）生活照料服务。例如：家政保洁、短期托养、助餐助浴、助急助行、呼叫代购等服务。养老需求的多样化要求提供有针对性的精准养老服务，必须变革养老服务形式，适时开展老年人综合能力评估和上门巡防探视，提升养老服务的效率和质量。

（二）医疗护理服务。例如：建立老年人健康档案，安排驻家医生，开展医疗优待、康复护理、体检保健、安宁疗护、中医针灸等服务。将医疗资源下沉延伸至社区甚至家庭，促进医疗与养老有效衔接，丰富了服务的内容；此外，社区养老机构与周边综合医院、药店诊所开展合作，建设急救绿色通道和分级转诊机制，提供定期送药上门服务，免除老年人就医后顾之忧。

（三）互助关爱服务。例如：法律救助、心理咨询、养老顾问等服务。通过设立法律救助站、心理咨询室，免费为老年人提供个性化的养老政策咨询、法律权益维护，精神心理疏导。

三、关系嵌入，调动老年人充分参与社区老年活动

人口老龄化并非社会老化，只是老年人的人力资源尚未获得充分开发利用。退休后的低龄健康老年人有大量闲暇的时间和精力，他们居住在社区中基于血缘、地缘等优势，通过相互交往，彼此结成稳定的社区关系网络，这对于养老服务和社区治理而言，是一种蕴含着巨大潜力的无形资产，它可以让社区形成邻里团结，守望相助的良好氛围。因此，要想充分调动老年人参与积极性，必须注重社区中信任关系和协作机制的培育。一方面，通过多渠道组织开展社区老年活动，利用情感关怀引导老年人主动融入社区，获得实现自我价值的成就感和回馈社会的认同感；另一方面，借助养老服务市场中多元主体的力量，调动政府、企业、家庭、社会组织及社区志愿者等各方有效衔接协同，推动多元主体秉承敬老孝义的精神共识，以社区为纽带打造全方位的社区关系网络，真正实现“老有所为”。主要包括：

（一）精神文化活动。社区中存在大量基于共同爱好的老年团体协会，为老

年人充分展示自身才华提供了舞台，开展的歌舞书画、体育健身、社区宣传、敬老孝义评选等各种休闲娱乐活动也已成为老年人日常生活中必不可少组成部分。鼓励老年人积极投身社区精神文化活动，让其能拥有一个健康、快乐、幸福、充实的晚年。

(二) 公益志愿活动。发展公益慈善的志愿服务是近年来社区治理的一种有效途径。借助社会非营利组织、社区志愿者、老年党员等力量，将公益志愿岗位引入社区养老服务领域，倡导老年志愿服务的“时间银行”行动，建立起由低龄老人帮助高龄老人的互助养老机制，组织动员社区中退休老年人参与到政策解读、文明劝导、疫情防控、治安巡防、协商自治等服务活动，实现老年人力资源的开发利用。

(三) 教育培训活动。尊重老年人受教育权利，大力发展老年教育事业，有助于老年人实现自我价值。因此，通过设立老年培训教育点或老年大学，根据老年人的兴趣爱好和身心特点，有针对性地开展消防安全、健康科普、防盗防诈、紧急救助、养老护理技能等方面的培训讲座，为老年人提供终身学习机会。

四、技术嵌入，构建智慧化养老体系

老年人运用信息技术困难，是在老龄化、信息化两大时代背景交织下产生的社会新问题，为解决老年人在运用智能设备和信息技术方面遇到的困难，让其更好共享科技发展成果，必须构建起智慧化养老体系。特别是新冠肺炎疫情期间，疫情防控对社区养老服务提出更高的要求，以云计算、大数据、物联网等信息技术深度嵌入社区养老服务工作，运用智能化设备，建立虚拟“居家养老院”，将养老业务由线下转移到线上，打造全天候响应、全闭环管理的智慧化信息技术网络，让养老服务更加便捷及时。主要包括：

(一) 养老信息管理系统。即养老服务的大数据中心和信息平台，通过集成养老、医疗甚至政务服务，不仅能有效整合养老资源，打破信息孤岛，为老年生活提供便利，而且可以做到操作全程留痕，为政府部门动态监测、分析数据并作出相应的决策提供有力支撑。

(二) 智能化设备。例如：一键呼叫报警器、智能手环、睡眠监测带、智能手机等。智能化设备可以实现社区老年人健康数据的实时监控，帮助随时掌握老年人身体状况，保持 24 小时的紧急救援响应。

(三) 数字化普及教育。构建智慧化养老体系不仅需要信息系统和设备终端等硬件支持，更需要培养老年人适应数字化社会的能力。一方面，开展“智慧助

老”、“我教老人用手机”等宣传培训活动，指导老年人轻松使用智能设备、APP 软件等工具。另一方面，充分考虑老年人的身体状况，保留人工柜台，提供线下办理业务窗口。

综上所述，要实现老年人养老不出社区，需要形成密集牢固的嵌入式结构类型网络。首先利用社区存量闲置空间建设微型养老机构，以较低成本实现周边养老资源的整合，形成完善嵌入式养老设施网络；其次，拓展养老服务功能，打造社区医养综合体，以提供全方位、多样化的医养结合养老服务，健全联盟式养老服务网络；再次，引入社会组织、公益团体负责或参与社区活动，增进老年人信任关系和再社会化能力，构建起紧密的社区关系网络；最后，借助“互联网+人工智能”，建立智慧化信息技术网络，提高社区养老工作的效率。各种网络之间彼此连结互动，建立起多层次的社区养老结构网络体系，促使家庭、机构、社区居家等养老服务模式的有机融合。

第四章 北京市朝阳区社区嵌入式养老服务模式的调查研究

本章主要是理论联系实际，以北京市朝阳区作为研究样本，从北京市养老政策的发展历程、朝阳区四个街道的实地调研和问卷调查，梳理总结出当前北京市社区嵌入式养老服务模式存在的问题，为后续建议的提出奠定基础。

第一节 北京市社区嵌入式养老服务模式的政策演变

作为我国最先进入老龄化的城市之一，2016 年北京市主动适应新时期国家积极应对老龄化战略要求，加快养老服务社会化，以“养老服务驿站”为特色重点推进社区嵌入式养老服务模式的创新探索，在此基础上制定了一系列具有地方特色、符合老龄化实际的养老政策，用于指导家庭、机构、社区居家等养老服务模式深度融合，为社区养老工作营造了良好的政策氛围。

为更好地掌握北京市社区嵌入式养老服务模式发展历程，本文一方面，从首都之窗、北京市民政局等官方网站收集发布的养老政策，确保资料来源的权威性、准确性；另一方面，关注朝阳社会建设和民政公众号、微博、知乎等媒体对北京市社区嵌入式养老服务模式的新闻报道，了解最新的养老实践成果。以“养老服务”作为关键词搜索出北京市 2016 年至 2020 年颁布的养老政策共计 137 条，经人工筛选整理出有关社区嵌入式养老政策 90 条。按照内容进行分类，具体分布如表 4-1 所示：

表 4-1 北京市社区嵌入式养老政策主要内容统计

序号	主要内容	数量
1	社区居家养老	27
2	医养结合	18
3	养老服务驿站	16
4	智慧养老	6
5	机构养老	5
6	老年综合能力评估	4
7	养老人才培养	4
8	社区老年参与	3
9	养老照料中心	3
10	法律维权	2
11	适老化改造	2

资料来源：作者根据北京市养老相关政策整理

由表可见，十三五以来北京市高度重视养老政策的制定工作，通过顶层设计推动社区居家养老与机构养老的跨界融合，加快养老服务驿站与养老照料中心的

规划建设,促进医养结合与智慧养老的规范和发展。同时针对老年综合能力评估、养老人才培养、社区老年参与、法律维权、适老化改造等领域也纷纷出台政策,为北京市社区嵌入式养老服务模式的规范化、科学化发展提供了法律保障。回顾其发展历程,可以划分为以下三个阶段:

一、萌芽探索阶段(2016年至2017年)

2016年,北京市作为全国首批26个居家和社区养老服务改革试点地区之一,在总结“9064”养老服务发展经验基础上,率先提出“养老服务驿站”概念,出台了《关于开展社区养老服务驿站建设的意见》、《社区养老驿站设施设计和服务标准(试行)》等一系列政策法规,首次明确在社区层面按照“十五分钟生活圈”的原则,采用“一址多点”、“以院统站”模式,在核心城六区试点养老服务驿站建设,开启了北京市社区嵌入式养老服务模式探索的序幕。为进一步加快养老设施网络的布局,2017年,北京市密集颁布养老服务驿站建设规划和运营扶持方案、养老照料中心建设资助和运营管理办法、居家养老服务发展“十条政策”等法条,将加快建设养老服务驿站纳入办好重要民生实事项目清单,在此基础上以区级养老指导中心、街道级养老照料中心等为突破点,形成“市老龄委—养老服务指导中心—养老照料中心—养老服务驿站”的四级养老设施网络,同时扩大养老机构对家庭上门养老服务的辐射范围,实现养老设施和养老服务有效衔接,形成“周边、身边、床边”养老服务结构,为北京市打造“三边四级”养老服务体系奠定良好的基础。

二、升级整合阶段(2018年至2019年)

2018年,随着十三届全国人大一次会议通过的国务院机构改革方案,全国老龄工作委员会、中国老龄协会由原来的民政部并入国家卫生健康委员会,养老主管部门的调整使得该时期的养老政策更加关注老年人的医疗健康需求,医养结合应运而生,成为养老领域发展的热点。在此背景下北京市社区嵌入式养老服务模式的政策风口逐渐由养老设施的建设向养老服务的升级转变,先后出台《关于推进医疗卫生与养老服务相结合的实施意见》、《养老机构与医疗机构医疗服务协议(示范文本)》等文件,加强社区养老与医疗机构联系,以推动更多医疗资源下沉基层,实现社区医养结合养老服务供给的均衡发展。例如:改革养老机构内设医疗机构执业许可证管理办法,简化流程手续,降低设立门槛,鼓励管辖范围内的养老照料中心、养老服务驿站等机构配置医护站;支持医疗机构到社区开设分支,派驻专职的医护人员,对小型卫生医疗服务进入社区实行准入备案制度,

同时全市首批设立 20 家老年友善医院, 170 家中医养老服务示范点, 指导养老机构与医疗机构建立起养老服务合作关系。2019 年, 为进一步巩固实施效果, 北京市将医养结合养老服务政策再次升级, 启动分级诊疗和医耗联动综合改革, 以差异化医保报销政策及医联体建设, 规范调整医疗服务项目, 取消药品和医疗耗材成本加成, 让普通常见病分流到社区, 提高老年人对基层医疗服务的可及性; 随后又相继推出了北京市居家养老服务系列规范、医疗与养老领域开放改革三年行动计划, 其中在社区老年综合评估标准、居家养老入户医疗服务清单、驻家医生签约管理、健康体检义诊活动、安宁疗护工作规范等方面都取得了积极进展, 逐步建立起老年人责任健康管理体系, 进一步提升北京市医养结合养老服务规范化、标准化水平。

三、深化发展阶段 (2020 年迄今)

2020 年作为十三五时期的收官之年, 是养老服务行业发展的分水岭。特别在当前社会人口老龄化加速和新冠肺炎疫情肆虐的双重压力下, 北京市对社区嵌入式养老服务模式进行重新调整, 以提升养老工作的前瞻预见性为重点、逐步补齐社区养老领域中的短板。例如在《北京市养老服务专项规划 (2020 年-2035 年) 》中就明确提出做好养老设施的规划布局, 鼓励在新建社区按一定比例配建试点社区嵌入式养老服务机构, 将养老服务驿站建设与养老照料中心协同建设, 为老年人提供就近养老服务。同时为完善北京市“床边、身边、周边”中“第三张床”建设, 制定《家庭养老照护床位实施办法 (试行) 》, 在原有的集中照料病床、临时托养病床的基础上, 开设家庭养老照护病床, 开展认知障碍管理和心理关爱项目, 将养老服务延伸至家庭, 使社区嵌入式养老服务模式向更精细化方向发展。此外, 随着智慧养老成为养老服务发展的着力点, 北京市先后制定《关于切实解决养老领域老年人运用智能技术困难有关工作的通知》、《关于在全市开展“智慧助老”行动的通知》等文件, 围绕“互联网+养老”创新养老服务方式, 建立全市统一的养老服务综合信息管理平台, 推动智慧型养老社区建设和智能养老产业发展。针对老年人关心的疫情防控、健康养生、智能设备应用等内容, 开展线上线下教育培训, 充分让老年人共享科技发展的成果。未来北京市将在新的起点上持续加码养老服务事业, 进一步促进家庭、机构、社区居家等养老服务模式的融合发展, 并着力打造老年友好型社区、十五分钟养老生活圈、长期护理保险、养老人才培养等新兴方向, 为社区嵌入式养老服务模式发展提供新的方案。

第二节 北京市朝阳区社区嵌入式养老服务模式的实地调研

一、调研设计

(一) 调研街道：根据社区嵌入式养老服务模式的主要特征和北京市人口老龄化实际情况，本次调研街道的选择满足以下两个条件：一是调研选择的四个街道 60 岁及以上老龄化率均超过 20%，都是老龄化较严重的区域；二是辖区内已建有养老照料中心、养老服务驿站、卫生服务中心等养老机构，并且实际运营状况良好，能提供医养结合等多样化的养老服务。在此基础上结合朝阳区不同类型、规模、特色的街道选择调研样本，保证收集数据既符合社区嵌入式养老服务模式的四个主要特征，也具有较好的普适代表性。

L 街道具有浓厚的敬老传统，辖区内社区卫生服务中心被评为全国敬老文明号，街道最大的亮点在于把敬老孝义融入社区养老工作方方面面，在组织动员社区老年参与志愿活动，弘扬尊老爱老孝义文化方面颇有建树；S 街道作为全国首批老年友好型社区申报示范点，在社区一刻钟生活圈、便捷交通出行、医养校企合作、老人帮扶结对等方面都做了诸多提升，利用智慧化的信息技术网络打造社区共建共治共享的养老格局；A 街道是北京市街乡区域医养联合体试点，利用辖区内雄厚的医疗资源试点实施中西医结合护理、医保互通异地结算、分级转诊等特色项目，着力破解医养结合养老服务落地难瓶颈；X 街道作为北京市老旧小区改造提升试点，将党建引领贯穿于适老化和无障碍的养老设施建设，积累了丰富的经验。具体基本情况如表 4-2 所示：

表 4-2 调研街道基本情况

调研地点	街道概况	街道老龄化特征	街道选择原因
L 街道	街道位于朝阳区东部，面积 4.4 平方公里，常住人口约 75229 人，辖区分为四环内和四环外，下辖 12 个社区。	60 岁及以上老人 20106 人，老龄化率 26.73%。其中，80 岁以上高龄老人 3747 人。	老年健康服务中心示范点，辖区内社区卫生服务中心被评为全国敬老文明号。
S 街道	街道位于朝阳区中西部，老旧工业区较多，面积 5.1 平方公里，常住人口约 93962 人，下辖 13 个社区。	60 岁及以上老人 21384 人，老龄化率 22.76%。其中，80 岁以上高龄老人 4063 人，空巢老人 2428 人，残疾老人 2143 人，失独老人 93 人。	老年友好型社区申报示范点。
A 街道	街道位于朝阳区西北部，地处东城、西城、海淀、朝阳四区交界，隶属奥运功能区。面积 3.6 平方公里，常住人口数约 57016 人，下辖 10 个社区。	60 岁及以上老人 17058 人，老龄化率 29.92%，其中，80 岁以上高龄老人 4018 人。	街乡区域医养联合体试点。
X 街道	街道位于朝阳区西北部，面积 2.58 平方公里，常住人口约 61966 人，下辖 8 个社区。	60 岁及以上老人 13128 人，老龄化率 21.19%，其中，80 岁以上高龄老人 2742 人，空巢老人 700 余人，残疾老人 981 人，失独老人 157 人。	老旧小区改造提升试点。

资料来源：作者根据调研访谈资料整理

由上表可以看出，被选择的四个街道老年人口数量多，老龄化比例较高，其中有不少属于高龄、空巢、失能以及失独老人，人口老龄化程度正在不断加深。再加上北京属于一线城市，人口聚集效应明显，朝阳区居住的老年人很多属于候鸟式老人，人口流动频繁，进一步增大了开展老年工作的难度。

(二) **调研对象**：本次调研的对象主要涉及北京市朝阳区政府及所辖街道社区中负责分管民政、老龄、卫健等领域的工作人员，养老服务驿站、卫生服务中心的负责人以及老旧小区改造开发商相关代表。

(三) **调研方式**：本次调研采用座谈走访方式，深入受访街道以及下辖社区，详细了解朝阳区嵌入式养老服务模式实际建设情况，结合北京市当前养老政策进一步总结经验，分析问题。

(四) **调研人数**：共计 70 人，其中座谈参与 30 人，走访参与 40 人。

二、北京市朝阳区社区嵌入式养老服务模式建设情况

随着老年人口数量的不断增多、养老需求的规模增大,北京市以推动养老照料中心、养老服务驿站等嵌入式养老设施建设为抓手,拓展医养结合养老服务、扩大社区老年参与、智慧化养老体系建设,逐渐构建起一套具有自身特色的嵌入式养老服务模式。具体如下:

(一) 嵌入式养老设施建设情况

“十三五”期间,北京市加大老年照料中心、养老服务驿站等机构建设力度,大力推进社区原有公共基础设施的适老化改造。截止 2020 年底,累计建设运营的养老照料中心 262 家,养老服务驿站 1005 家,卫生服务中心 175 家,卫生服务站 353 家,专业养老机构 544 家;累计完成 155 个老旧小区近 900 栋楼改造工作,住宅安装适老化设施 15800 余户,整改公共无障碍设施 41.8 万处,加装电梯 1843 部,初步形成“三边四级”便民养老设施网络格局^①。其中,调研街道的具体情况如表 4-3 所示:

表 4-3 调研街道嵌入式养老设施建设具体情况

调研街道	具体内容
L 街道	街道拥有 2 家养老照料中心、5 家养老服务驿站、1 家医院,1 家卫生服务中心,6 家社区卫生服务站。养老设施建设注重与敬老精神文化相融合,例如:专门建立敬老文化公园、敬老文化街巷,孝星敬老院等公共场所,场所内配套图书馆、健身器械、儿童游乐园和尊老助老宣传长廊等文化娱乐设施。
S 街道	街道拥有 2 家养老照料中心、5 家养老服务驿站、5 家医院,2 家卫生服务中心,6 家社区卫生服务站。养老设施建设突出老年宜居概念,强调老年人居住、出行的安全高效便捷,例如:成立无障碍设施建设专项行动工作领导小组,定期召开专题调度会,打造“无障碍精品示范街区”和“一刻钟无障碍便民服务圈”。
A 街道	街道拥有 2 家养老照料中心、7 家养老服务驿站、3 家医院,3 家卫生服务中心,4 家社区卫生服务站。养老设施建设以医养结合为重点,引入急救助理念,创新设立生活服务站、急救救助站、“便民 365”服务站、文化活动站,配备消防安全工具,康复器材,急救箱、血压计、红十字会爱心药箱等“为老服务包”,组建健康医疗养老联盟。
X 街道	街道拥有 1 家养老照料中心、4 家养老服务驿站、1 家医院,1 个卫生服务中心,2 家社区卫生服务站。养老设施建设借助老旧小区改造为契机,对社区养老细节进行人性化提升,例如:住宅内安装扶手、闪光门铃、爬楼机等适老化设备,公共区域全部进行无障碍改造,合理规划交通,实现人车分流,提升道路和街角微景观。

资料来源:作者根据调研访谈资料整理

^① 北京市卫生健康委员会官网.北京市老龄事业发展报告(2020)[EB/OL]. http://wjw.beijing.gov.cn/xwzx_20031/xwfb/202110/t20211014_2512063.html. 发布时间 2021 年 10 月 24 日.

（二）医养结合养老服务供给情况

随着近年来实施老年健康北京战略深入，全市通过推动医疗与养老机构签约合作，加大在养老服务内容形式上的创新，新增预约挂号、分级转诊、康复保健、安宁疗护、针灸中医、心理关爱等特色的医养结合养老服务。同时建设综合医联体，推进驻家医生签约服务，将医养结合养老服务延伸至社区和家庭。截止 2020 年底，全市共建成 62 个综合医联体，544 家养老机构实现医疗服务全覆盖；组建驻家医生团队 5170 个，为老年人提供上门医养结合养老服务 130.86 万人次^①。其中，调研街道的具体情况如表 4-4 所示：

表 4-4 调研街道医养结合养老服务供给具体情况

调研街道	具体内容
L 街道	街道组织“养老服务四进家庭”、“为老服务大集”、“爱在夕阳·资源联动——1+3+X”等活动，在养老服务中凸显对老年人的情感关怀，弘扬敬老文明精神。其中，最大特色是社区卫生服务中心将敬老精神注入医养结合养老服务中，践行厚德明礼，仁爱行医原则，建立不同岗位敬老文明礼貌用语标准，将养老服务态度列入员工职业道德考核指标，收集老年人对员工敬老服务评价作为年度优秀评比的参考因素。
S 街道	街道开展“众享医养服务圈”项目建设，实行校企合作，积极培养医务社工，不断拓展医养结合的范围。例如：参与美国耶鲁大学医学院 PACE 项目合作，重点聚焦社区老年人认知障碍、精神疾病的防治，打造一流社区康复团队；联合辖区内综合三甲医院、中国老年保健协会对医务工作者及社区志愿者进行老年人慢性疾病管理的专业培训，提升医护工作者的专业医疗水平。
A 街道	街道作为朝阳区综合医联体试点，在推进医养结合上有诸多亮点，例如：联合北京市医疗行业协会、专业医疗机构与辖区内 52 家养老机构签订医养联合体合作协议，组建健康养老联盟；借助辖区中医、康复等特色专科，重点围绕老年疾病的诊治护理、安宁疗护、康复照料、中医针灸推拿打造中西医结合+康复矫治+中医适宜技术+心理干预等多学科于一体的老年康护和医养结合服务体系。
X 街道	街道以养老照料中心及养老服务驿站为基础，将辖区内的养老资源与医疗资源相结合，实现优势互补。例如：采取集中配送中心“1+X”助餐服务试点项目，即 1 个老年餐食配送中心为周边医疗机构配餐；同时引进华润、江中等大型医药企业，连接综合医院、诊所、药店等医疗机构开展家医签约、日常巡诊、健康处方和送药上门等一站式医疗服务，实现对老年人全周期的健康医疗管理。

资料来源：作者根据调研访谈资料整理

^① 北京市卫生健康委员会官网. 北京市老龄事业发展报告（2020）[EB/OL]. http://wjw.beijing.gov.cn/xwzx_20031/xwfb/202110/t20211014_2512063.html. 发布时间 2021 年 10 月 24 日.

(三) 社区老年参与活动开展情况

北京市高度重视老年人的精神文化需求,围绕社会主义核心价值观,利用敬老月发布《爱要大声说出来》,加大人口老龄化国情的宣传教育,组织“志愿北京之青春伴夕阳”项目,倡导老年人发挥余热,积极参与志愿服务活动。截止2020年底,全市实名注册60岁及以上志愿者共有106.946万人,开展助老志愿活动2338场次^①。其中,调研街道的具体情况如表4-5所示:

表 4-5 调研街道社区老年参与活动开展具体情况

调研街道	具体内容
L 街道	街道崇尚敬老孝义文化,在传统重阳节、春节等重大节日组织百家宴、灯谜会、为老年人赠送康乃馨、毛衣等爱心礼物,举办“尊老助老,筑爱夕阳”、“每日‘益’点——社区众创行动”等活动,拉近社区与老年人之间距离,积极开展慈善公益。
S 街道	街道将共享养老和助老结对相结合,通过开展“帮扶助老进家门”、“巧手小老暖大老”、“共享养老生日会”、“共享养老暖心甜”等活动建立起老年人邻里守望的信任关系,组建了一支“社区桑榆情”老年志愿者团队。
A 街道	街道利用自身丰富医疗资源,将健康养老理念融入社区公益活动,在辖区内开展中医养生、紧急抢救、疫情防控等医养公益课程讲座;定期进行社区老年义诊,打造“首诊在社区”;举办健康宣传周,组织老年人家属和社区志愿者共同参与座谈联欢活动;此外,发起社区公益基金会,帮助低保、特困老年群体解决生活难题。
X 街道	街道设立社区活动之家,发挥老旧小区改造中党建引领作用,利用党员带头开展防盗诈骗、居家安全、垃圾分类等培训讲座;同时与国家开放大学联合开设“长者初心学堂”,弘扬红色精神;此外,结合建党100周年契机,试点“街院党建”探索新型助老机制,通过党建学习积分奖励老年人参与社区协商议事。

资料来源:作者根据调研访谈资料整理

(四) 智慧化养老体系构建情况

为使老年人享受到互联网信息技术带来的红利,北京市围绕“互联网+养老”,打造了全市96156居家养老服务平台,开通“乐享银龄”微信公众号,以智能化设备和数字化教育活动推动信息技术网络升级,实现科技成果转化与老年人需求精准对接,使养老服务发展走上良性循环轨道。其中,调研街道的具体情况如表4-6所示:

^① 北京市卫生健康委员会官网.北京市老龄事业发展报告(2020)[EB/OL].http://wjw.beijing.gov.cn/xwzx_20031/xwfb/202110/t20211014_2512063.html. 发布时间2021年10月24日.

表 4-6 调研街道智慧化养老体系构建具体情况

调研街道	具体内容
L 街道	街道重点推进养老服务大数据及服务云平台建设，整合电子政务应用，申报“老人居家检测平台项目”，拓展传感终端和网络使用，通过安装老年人睡眠监测带、一键呼叫报警器、实现居家环境实时监控和自动报警，打造微型“居家养老院”。
S 街道	街道统筹辖区内 13 个社区的信息系统打造统一的数字虚拟社区平台，逐步提高养老服务驿站、周边商业配套等业务的线上接入率，提供养老服务咨询、预约、回访等功能，辅以多种支付方式，支持面部、指纹识别或刷身份证、老年卡、二维码等，方便老年人日常生活采购。
A 街道	街道着力打造“互联网+医疗护理”，实施二级以上医疗机构非急诊全面预约就诊，通过线上预约挂号，联盟综合体医保实时结算，开设远程问诊，提供 24 小时紧急救助，为老年人提供便捷的就医体验。
X 街道	街道打造智慧型社区，使社区安全与物联网相结合，通过安装增设烟雾报警器、红外感应垃圾桶、人脸识别系统、24 小时视频监控、感应式门禁等设备，全天候为社区老年人的安全保驾护航。

资料来源：作者根据调研访谈资料整理

从调研的街道可以看出，目前北京市朝阳区社区嵌入式养老服务模式已经初具雏形，形成了以养老照料中心和养老服务驿站为主体的养老设施网络，同时借助朝阳区丰富的医疗资源，大力组建综合医联体，提供一站式医养结合养老服务使老年人足不出户就能得到全方位的照顾，而社区丰富多样的助老活动和区域智慧养老体系的完善，打造出十五分钟养老生活圈，进一步提升了朝阳区养老服务水平和质量。同时由于老年人口结构、社区资源禀赋等因素不同，朝阳区各街道发展社区嵌入式养老服务模式具有各自独特的优势，例如：L 街道的敬老孝义、A 街道的医养结合、S 街道的老年友好、X 街道的党建引领等。各街道将自身优势与探索实践充分融合，为我国其他地区推广社区嵌入式养老服务模式积累了宝贵的经验。

第三节 北京市朝阳区社区嵌入式养老服务模式的问卷调查

一、问卷调查设计

- (一) 问卷调查时间：2021 年 8 月开始到 2021 年 10 月结束，历时 3 个月。
- (二) 问卷调查对象：上述四个街道辖区内 60 岁及以上老年人。
- (三) 问卷调查发放情况：共发放 300 份问卷，收回 253 份，问卷回收率为 84.33%，其中 60 岁及以上老年人 236 份，占比 93.28%，60 岁以下老年人 17 份，占比 6.72%。按照 60 岁为统计标准，问卷以 60 岁及以上老年人的 236

份为基数进行分析，有效回收率为 78.67%。

二、北京市朝阳区社区嵌入式养老需求问卷调查情况

(一) 问卷调查老年人基本信息

本次问卷调查老年人的具体基本信息如表 4-7 所示：

表 4-7 问卷调查老年人基本信息

项目	分类	人数	占比	项目	分类	人数	占比
性别	男	89	37.71%	文化程度	初中以下	51	21.61%
	女	147	62.29%		高中	109	46.19%
年龄（岁）	60~65 岁	91	38.56%		本科	67	28.39%
	65~70 岁	69	29.24%		硕士研究生及以上	6	2.54%
	70 岁以上	76	32.20%		其他	3	1.27%
居住情况	夫妻与子女同住	78	33.05%	自理状况	健康，完全自理	74	31.36%
	夫妻同住	110	46.61%		患有慢性疾病，基本自理	127	53.81%
	子女同住	17	7.2%		患有重大疾病，不能自理	16	6.78%
	单独居住	24	10.17%		残疾人士	18	7.63%
	其他	7	2.96%		其他	1	0.42%

资料来源：作者根据调查问卷数据整理^①

由上表可见，从性别来看：主要以女性老年人为主，占到 62.29%，而男性老年人仅占 33.27%，这也表明女性老年人更乐于参与社区活动；从年龄来看：每个年龄段老年人分布比较均匀，其中 65 岁以上高龄老年人占比较高；从居住情况来看：近六成老年人没有与子女一起居住，经调研发现主要因为北京市独生子女家庭多，老年人子女数量总体较少，空巢化严重；从自理状况来看：八成以上老年人生活基本能够自理，但仍有不少患有长期慢性疾病，表明随着老年人身体机能衰弱，对多样化的养老需求逐渐旺盛；从文化程度来看：超过七成的老年人取得高中及以上学历，表明朝阳区老年人受教育水平较高，对新式养老服务内容和方式都易于接受；此外，根据受访老年人反映，随着近年来北京地区养老退休金增长，生活质量逐渐提高，老年人的日常活动已不再局限于进行家务劳动和照料儿童等方面，而更多的是关注健身娱乐、旅游养生、志愿服务等休闲活动，希望能充实单调乏味的晚年生活。这些都表明北京市发展社区嵌入式养老服务模式的潜力十分巨大。

^① 注：占比为各项目分类所对应人数/问卷分析基数（236）

(二) 问卷调查老年人养老需求情况分析

受居住环境、身体状况、收入水平、教育层次等因素影响,老年人对养老需求存在差异,以重要性来衡量老年人对养老需求的迫切程度,摸清老年人对养老服务的真实意图,为下一步分析北京市社区嵌入式养老服务模式存在的问题奠定基础。本次问卷调查结合社区嵌入式养老服务模式的主要特征从嵌入式养老设施、医养结合养老服务、社区老年参与和智慧化养老体系等四个维度制定指标选项,考察北京市朝阳区老年人的具体养老需求情况。

1、嵌入式养老设施重要性分析

在嵌入式养老设施方面,如下图 4-1 所示:受访老年人对社区治安及消防安全设施的重要性需求最高,达到 92.37%,其次分别为便民微型养老机构(91.53%),公共场所无障碍设施(90.68%),交通道路指示照明设施(89.41%),住宅适老化改造(87.29%),社区周边配套设(74.58%)。由此可见,社区治安及消防安全是社区居住环境中老年人最重视的问题,发放问卷中许多老年人表示社区特别是老旧小区缺少物业管理,居住安全隐患较多,容易发生意外事故。同时由于老年人行动不便,设施距离也是其关注的重点,从统计数据上可以看出,便民微型养老机构的重要性远高于社区周边配套设,表明老年人对交通出行改造意愿也十分迫切。

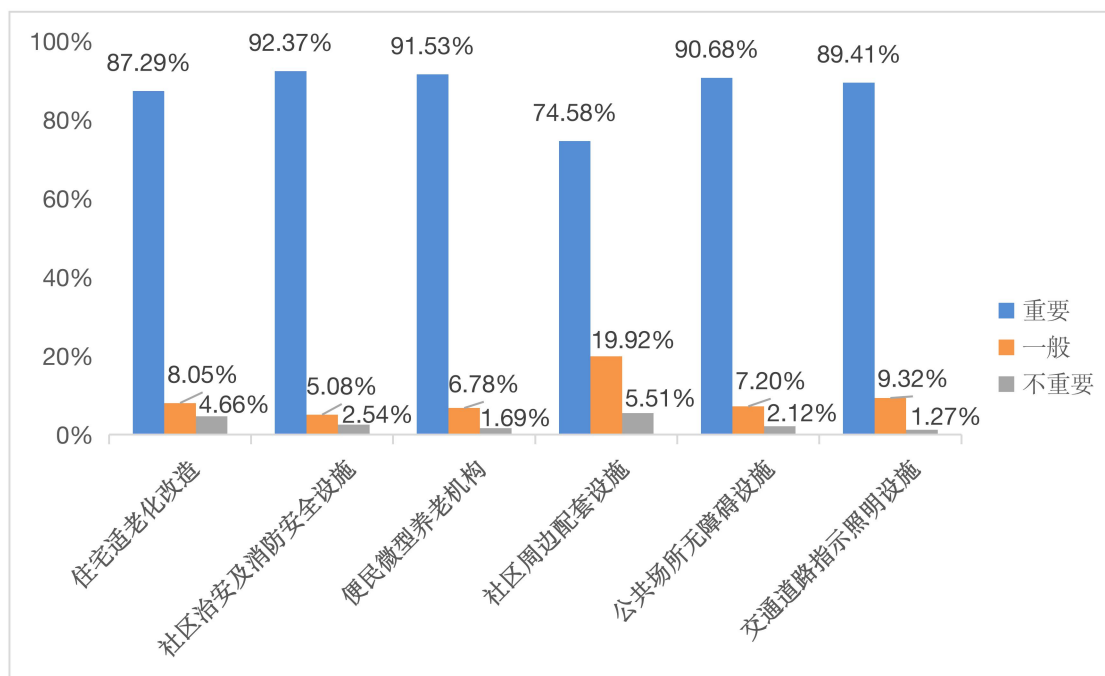


图 4-1 嵌入式养老设施重要性分析

资料来源: 作者根据调查问卷统计情况整理

2、医养结合养老服务重要性分析

在医养结合养老服务方面，如下图 4-2 所示：受访老人认为最重要服务项目分别是：医疗护理（86.44%），生活照料（76.27%），法律援助（75.85%），心理咨询、情感陪伴（68.64%）。由此可见，随着老年人身体机能的逐渐衰退，生活自理能力受到很大限制，医疗护理、生活照料等日常养老服务依然是老年人急需的重点，而对法律援助，心理咨询、情感陪伴等个性化服务需求相对较低，未来还有进一步提升的空间。

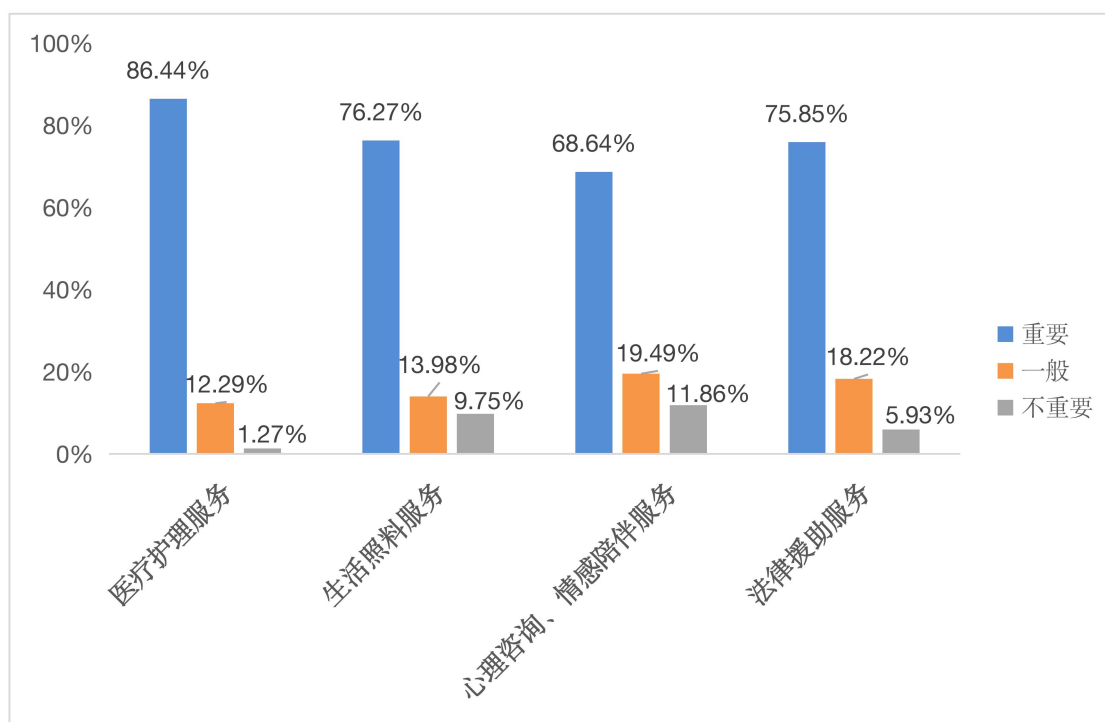


图 4-2 医养结合养老服务重要性分析

资料来源：作者根据调查问卷统计情况整理

3、社区老年参与重要性分析

在社区老年参与方面，如下图 4-3 所示：受访老年人认为最重要的社区参与活动分别是：文化体育娱乐活动（86.02%），公益志愿互助活动（85.59%），老年教育及培训活动（85.17%），敬老主题宣传评选活动（80.08%），居民自治管理议事活动（79.24%）。由此可见，大多数老年人都有强烈集体意识，希望通过参与文体娱乐活动来增加沟通交流的机会，增进彼此间的信任和联系，建立老年人情感共同体，同时老年人对社区协商议事重视度较低，老年人的人力资源优势尚未得到充分发挥。

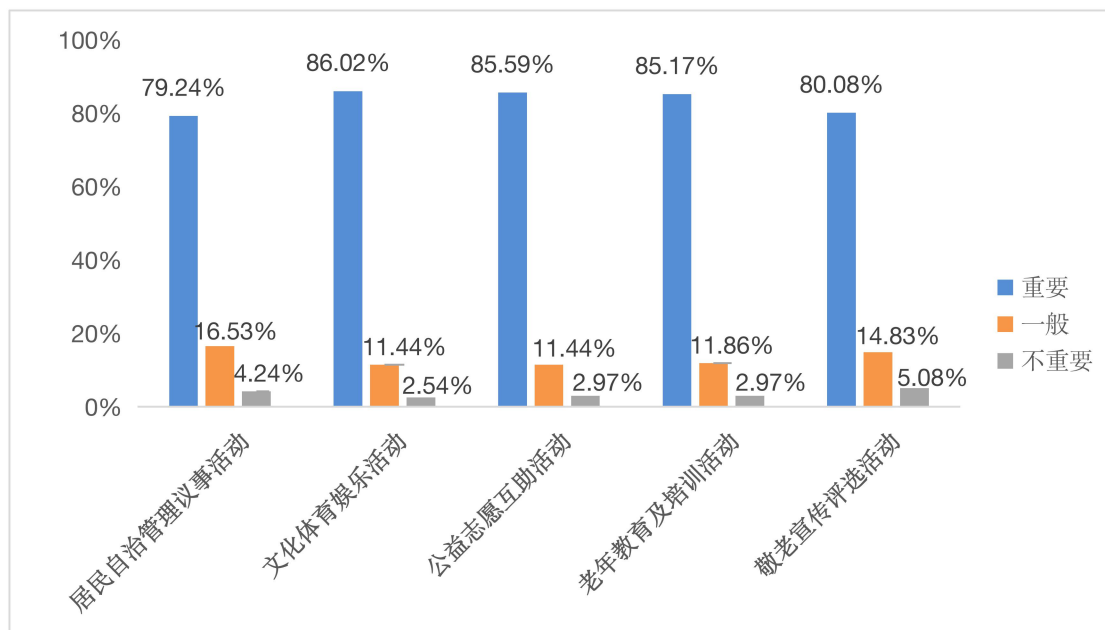


图 4-3 社区老年参与重要性分析

资料来源：作者根据调查问卷统计情况整理

4、智慧化养老体系重要性分析

在智慧化养老体系方面，如下图 4-4 所示：受访老年人认为最重要的智慧化项目分别是：保留传统线下服务（83.47%）、线上远程平台（80.51%）、智能设备培训指导（76.69%）。由此可见，当前老年人普遍面临着“数字鸿沟”问题，主要体现在智能设备使用率低、线上业务流程复杂等方面，希望保留传统线下人工服务，并且在智能设备的使用上获得一定的帮助。

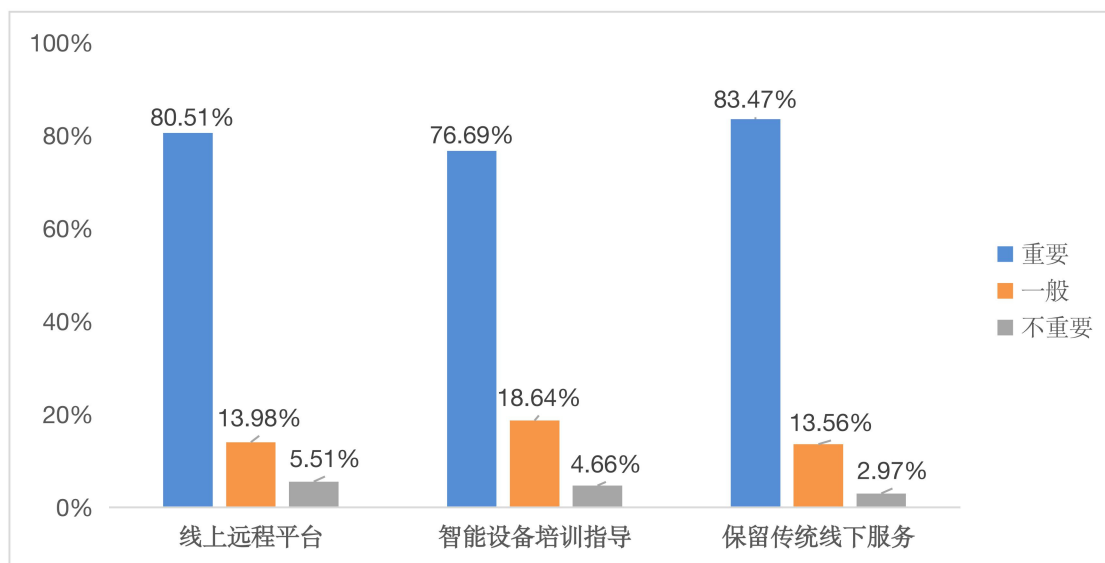


图 4-4 智慧化养老体系重要性分析

资料来源：作者根据调查问卷统计情况整理

为进一步分析老年人对社区养老需求的总体评价程度,按照问卷调查答案选项“非常重要”、“比较重要”、“一般”、“不太重要”、“不重要”分别赋值“5”、“4”、“3”、“2”、“1”,将各选项对应分值乘以重要性占比,即得到受访老年人对社区养老需求重要性各项指标的总体评价。调查具体结果如表 4-8 所示:

表 4-8 社区养老需求重要性评价的总体情况

	非常重要		比较重要		一般		不太重要		不重要		总体重要性
	人数	占比	人数	占比	人数	占比	人数	占比	人数	占比	
住宅适老化改造	149	63%	57	24%	19	8%	3	1%	8	3%	4.42
社区治安及消防安全设施	161	68%	57	24%	12	5%	2	1%	4	2%	4.56
便民微型养老机构	156	66%	60	25%	16	7%	2	1%	2	1%	4.55
社区周边配套设施	98	42%	78	33%	47	20%	5	2%	8	3%	4.07
公共场所无障碍设施	152	64%	62	26%	17	7%	0	0%	5	2%	4.51
交通道路指示照明设施	151	64%	60	25%	22	9%	0	0%	3	1%	4.51
嵌入式养老设施											4.44
医疗护理服务	150	64%	54	23%	29	12%	3	1%	0	0%	4.49
生活照料服务	116	49%	64	27%	33	14%	12	5%	11	5%	4.11
心理咨询、情感陪伴服务	102	43%	60	25%	46	19%	11	5%	17	7%	3.93
法律援助服务	118	50%	61	26%	43	18%	8	3%	6	3%	4.17
医养结合养老服务											4.17
居民自治管理议事活动	122	52%	65	28%	39	17%	5	2%	5	2%	4.25
文化体育娱乐活动	136	58%	67	28%	27	11%	4	2%	2	1%	4.40
公益志愿互助活动	123	52%	79	33%	27	11%	4	2%	3	1%	4.33
老年教育及培训活动	126	53%	75	32%	28	12%	5	2%	2	1%	4.35
敬老宣传评选活动	116	49%	73	31%	35	15%	8	3%	4	2%	4.22
社区老年参与											4.31
线上远程平台	115	49%	75	32%	33	14%	6	3%	7	3%	4.21
智能设备培训指导	112	47%	69	29%	44	19%	4	2%	7	3%	4.17
保留传统线下服务	128	54%	69	29%	32	14%	5	2%	2	1%	4.34
智慧化养老体系											4.24

资料来源:作者根据调查问卷统计情况整理

经过统计分析发现,在问卷调查中各项指标都在 3.5 分以上,超过 3 分的中位数,表现出很高的重要性,表明这四大维度基本都是老年人普遍关心的养老需

求。具体而言，在四大维度中，受访老年人的总体重要性排序分别为嵌入式养老设施（4.44）、社区老年参与（4.31）、智慧化养老体系（4.24）、医养结合养老服务（4.17）。可见嵌入式养老设施建设即与老年人生命安全息息相关，也影响到老年人在社区居住环境的良好体验，因此一直是其关注的重点。而从单项上看，总体重要性最高的是社区治安及消防安全设施（4.56），主要由于朝阳区属于北京市面积最大主城区，建设历史悠久，存在大量的老旧小区，缺乏物业管理，居住空间拥挤狭窄，线路、消防等设施老化，极易引发盗窃、火灾等安全隐患，因此老旧小区改造工作任重道远。而总体重要性最低的是心理咨询、情感陪伴服务（3.93），这说明老年人的精神心理健康往往被忽视，容易使其产生抑郁孤独、恐惧焦虑、敏感猜疑、自责内疚等一系列心理问题，而受勤俭节约的传统消费观念影响，老年人付费购买咨询陪伴服务的意识尚未建立。因此，需要社会各界更多的关怀与爱护，主动沟通交流帮助老年人解决心理健康问题。

第四节 北京市朝阳区社区嵌入式养老服务模式的存在问题

北京市社区嵌入式养老服务模式兼顾了家庭养老服务模式的情感、机构养老服务模式的专业、社区居家养老服务模式的地缘等特点，在资源整合、服务效率、情感关怀、科技应用等方面具有优势。但同时该模式正处于发展初期阶段，实施过程中难免存在政策、设施、服务、资金、人员等制约，结合北京市朝阳区受访街道的调研情况，分析其存在问题，主要表现在以下六个方面：

一、政府统筹协调能力有待加强

北京市在当前老龄委并入卫健委的大背景下，两大部门在养老管理工作上仍然处于磨合期，存在部门责任不明、岗位分工不清，政策不稳定等问题，使得社区养老工作的管理呈现零散化、碎片化。主要表现在：一方面，政府在养老工作统筹上合力不够。主管养老事务的相关部门科室各自为政，工作职责和岗位范围模糊重叠，遇事不作为，互相推诿，加上市级层面尚未形成有效组织机制，造成社区养老工作推进缓慢，难以统一。以北京市养老和医疗系统网络为例（如下图4-5所示），两大系统彼此独立，使各级养老资源和医疗资源难以真正实现互补，导致社区医养结合改革发展相对滞后；另一方面，政府在政策的制定上缺乏沟通，政策执行上落实不到位。具体而言，上级缺乏对基层的养老工作指导和业务交流，无法真正掌握实际执行效果，基层只是被动接受养老任务摊派，没有主动汇报工作的动力，导致颁布的养老政策与基层实际脱节，颁布的政策缺乏延续性，变动

频繁，严重影响社区养老机构的后续运营。

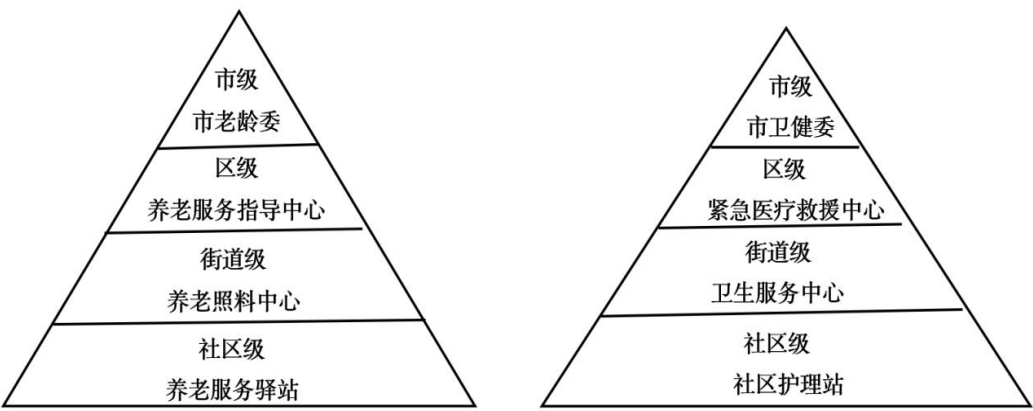


图 4-5 北京市养老和医疗系统网络图

有些时候政策的变化非常频繁，比如现在不知道明年这个时候养老服务驿站的流量补贴还会有不会有。各项政策间标准也不统一，针对同一个项目，今年按着服务流量来补贴，明年可能按照家庭床位补贴，而想做好家庭床位需要有资质和星级，只有两星级以上才有资格承接家庭床位获得补贴，因此，政策稳定性和统一性是个问题。

(访谈对象，朝阳区 A 街道养老服务驿站负责人，访谈时间 2021 年 7 月 7 日)

二、社区嵌入式养老设施整合错位

受到土地、产权、资金等因素的制约，城市中可开发的公共资源有限，而社区嵌入式养老设施规划建设缺乏整体布局，导致设施整合错位，利用效率低下，不利于构建全覆盖的社区养老设施网络。主要表现在：一方面，社区嵌入式养老设施整合力度不够，造成设施配置和养老服务存在“盲区”，网络衔接度不够，难以实现对区域内全体老年人养老服务的有效覆盖。例如：养老服务驿站分布不合理、综合性三甲医院与社区卫生服务站就医求诊人数倒挂、社区内外无障碍人行道无法闭环等；另一方面，嵌入式养老设施建设与老年人需求脱节。朝阳多数社区为老旧小区，在开展适老化和无障碍改造前缺乏全面、系统、深入的调研，造成实际改造方向与老年人真实诉求不符。具体而言，结合问卷调查来看，在社区居住方面，当前改造主要集中住宅内扶手、座椅、防滑地面等内容，缺少老年人关注的安全消防、遮阴挡雨、挂钩等设施配置；在交通出行方面，老旧小区电

梯安装缓慢，便利商店门前存在较高门槛，老年人出行体验较差。

现在我们街道的 5 家养老服务驿站全部分布在四环内，而管辖范围较大的四环外区域还没有 1 家养老服务驿站，造成养老资源分布极不平衡，已建成的养老服务驿站的占地面积也非常小，没有必要的活动场地，养老服务驿站没有发挥出它该有的功效，存在“叫好不叫座”的现象。

(访谈对象，朝阳区 L 街道社区建设办公室科长，访谈时间 2021 年 6 月 21 日)

老年人对于一些头痛小病也热衷于去三甲医院而不是社区卫生服务站，使社会当前就医求诊处于一种倒三角金字塔结构：即上面三甲医院的人最多，下面反而是人少，这是一种不稳定的状态，容易造成大型医院资源紧张而社区医疗资源闲置浪费。

(访谈对象，朝阳区 S 街道第二社区卫生服务中心负责人，访谈时间 2021 年 6 月 21 日)

三、医养结合养老服务供需失衡

医养结合养老服务的供给不足，潜在养老需求未能有效激活，导致养老服务供需渠道不畅，养老服务网络尚未完全建立。主要表现在：从供给角度来看，当前养老服务驿站主要依靠政府流量补贴维持运营，尚未形成市场化的连锁规模，造成开展医养结合养老服务成本较高，加上受医保政策、新冠肺炎疫情等因素影响，线下及上门服务都受到严重影响，持续运营面临较大压力，阻碍了养老服务正常供应。例如：目前北京市医保政策对于医养结合的服务范围有严格限制，无法报销上门康复类服务项目；从需求角度来看，受养老政策宣传不足、收入水平低以及保守节俭观念等因素影响，老年人的养老服务消费能力和意愿较低，客观上限制了老年养老消费市场需求增长。根据问卷调查发现，老年人对医疗护理的需求强烈，但由于北京市高龄、失能养老津贴金额较少，使用范围过窄，致使老年人无法承受高价的医疗服务，同时开展一些简单的上门服务也需要老年人拍照签字，流程手续繁琐，进一步抑制了老年人的消费需求。

养老服务驿站由于体量小，服务人手不够，很多服务供应跟不上，加上基础性养老服务收费低，基本不挣钱，特别是在 2020 年新冠肺炎疫情期间，其他上门服务全部停滞，基础老年餐、代购商品的业务量又没有那么少，驿站运行面临巨大压力。

(访谈对象，朝阳区 X 街道某养老服务驿站负责人，访谈时间 2021 年 7 月

7日)

现在北京市医保限定范围，很多治疗类项目只允许到医院而不能居家开展，这就把上门医养服务限定死了。因为医保和卫健委是两条线，很多时候是矛盾的，卫健委希望可以给老年人提供更多健康服务，医保则是考虑怎么花钱最少，不太考虑整体服务上效果。因此即使政策允许我们做一些上门的康复类服务，但是不纳入医保报销范围，很多老人患病后行动不便没法去医院，只能居家进行康复，有上门服务需求，但是由于没有解决支付端问题，使得居家上门无法持续。

(访谈对象，朝阳区S街道第二社区卫生服务中心负责人，访谈时间2021年6月21日)

四、老年人社区参与水平不高

社区关系网络的建立不仅需要于政府、企业、社会和家庭介入，更依赖于老年人自身的参与。北京市高度重视老年人的精神文化建设，组织社区开展了形式多样的活动，但都收效甚微，老年人仍然处于“弱参与”状态，难以发挥出老年人丰富的人力资源潜力。具体而言：结合问卷调查，从参与的内容上看，主要集中在运动健身、休闲娱乐等文体活动，社区缺乏沟通互动渠道，对协商议事、公益慈善的热度不高；从参与群体来看，低龄女性老人是社区参与的主力军，基层党支部建设滞后，无法发挥社区党员及精英骨干的带头作用；从参与意识方面看，老年人积极老龄化观念尚未树立，多为带有目的性的被动式参与，没有主动参与、热心助人的动力，无法形成良好的社区参与激励机制。

每次举办老年人社区活动都是那几个热心的阿姨参加，而且她们参与主要是为了获取礼品恩惠，缺乏积极主动参与意识。而在社区居民当中的骨干、能人相对较少，主要还是依靠退休老党员响应，无法真正动员起社区其他老年人参与积极性。同时老年人很少关注社区公益和集体事务，12345热线变成老年人宣泄生活琐事的渠道。

(访谈对象，朝阳区L街道社区居委会工作人员，访谈时间2021年6月21日)

五、智慧养老存在“非智能化”

在本次调研中发现，北京市朝阳区各街道都在努力打造自身的养老信息平台，也提供了较丰富的智能设备和线上服务，但整体的信息技术网络联结程度不足，整合资源和服务的力度不够，使智慧养老存在“非智能化”现象。主要表现在：各街道开发的信息平台仅联结辖区内网，彼此之间数据互不连通，也无法与

市卫健委、市民政局等部门进行信息共享，无形中造成养老信息资源的闲置和浪费。同时各街道打造的信息技术网络目前仍停留在为老年人日常生活便民业务提供技术支持阶段，难以突破单一行业和领域的桎梏，无法与社区养老设施网络、养老服务网络、社区关系网络等形成有效衔接。此外，现阶段不少社区内智慧养老建设热衷于搞“一刀切”，取消线下人工窗口，将各项业务全部转到线上办理，同时又忽视社区数字化教育培训，容易给不会使用智能设备及线上软件的高龄、失智等老年群体造成困扰。

街道辖区内信息平台属于 1.0 版本，只能作为信息收集和派单服务，今后预计绑定更多餐饮、家政、保洁等生活服务商，升级为 2.0 版本，但没有太大意义。因为每个街道开发各自系统、APP，相互独立隔离，信息封闭，需要运营商花费大量时间熟悉操作，无法实现真正信息化。同时虽然市卫健委对高龄、失能老年人具有更详细具体信息，但接口不开放共享，造成医疗资源无法与街道的平台对接，只要老年人迁走，离开所属地之前的数据和记录就无法实现迁移。

(访谈对象，朝阳区 X 街道办事处民政科工作人员，访谈时间 2021 年 8 月 31 日)

六、社区嵌入式养老缺乏资金和人才支持

养老产业具有准公益性，需要投入大量的资金支持，但目前养老资金短缺一直是制约社区嵌入式养老服务模式可持续发展的重要问题。主要表现在：一方面，社区养老设施的建设运营面临资金压力。由于北京市养老照料中心、养老服务驿站等机构主要采用“公建民营”模式，建设前期需要财政投入大量资金，再加上受用地政策、融资渠道等限制，致使养老机构实际运营成本较高，利润率低，投资回收周期长，入不敷出的资金缺口常常使社区养老设施建设、运营捉襟见肘；另一方面，社区老年活动缺乏经费支持。自从北京市老龄委合并入卫健委后，对老年工作的管理逐渐呈现弱化趋势，集中体现在财政预算上没有单独列支养老经费。根据调研了解，目前朝阳区大部分街道在开展老年活动时主要使用社区党群活动经费，然而该经费主要服务于党员群体，无法使社区全体老年人受益。此外，社区党群活动经费每年数量变化较大，也使老年活动缺乏延续性，进一步减少老年人参与社区活动机会。

我们驿站是 2018 年通过共建协议进来的，街道当时无偿提供了场地，同时给予水电、税费等优惠，确实缓解了一部分前期资金困难，但是仍然是杯水车薪，驿站运营聘请人工、设备维护、日常管理等方方面面都需要花钱，单纯依靠驿站

政府补贴和基本业务收入远远不够，都是亏损运营。

(访谈对象，朝阳区 X 街道某养老服务驿站负责人，访谈时间 2021 年 7 月 7 日)

民政方面没有老年工作的专门资金，前几年老龄委有老年餐桌经费，现在资金投入取消了，很多老年活动、培训讲座主要依靠党群活动经费，从党建引领角度聘请第三方来为老党员提供中医养生、文艺汇演等丰富老年人生活的活动，老年人反响挺好的，但是由于经费没有保障导致活动缺乏延续性。

(访谈对象，朝阳区政府民政局工作人员，访谈时间 2021 年 8 月 31 日)

由于社会地位低、薪酬待遇差、职业发展空间小、工作强度大等原因，养老服务岗位缺乏就业吸引力，现有的养老服务人手不足，使社区养老工作滞后，养老服务效果也难以保障。主要表现在：首先，社区养老服务队伍整体规模小，数量少，内部性别结构不合理、年龄结构偏大，无法为社区形成稳定的养老服务供给；其次，当前社区缺乏高端专业的养老人才，从业人员学历水平和专业素能参差不齐，服务水平和质量低，难以满足老年人在养老、医疗等方面更高的诉求；最后，养老服务人才的教育培训方式单一落后，缺乏实质性人才激励政策和权益调解机制，导致人员流动性大，不利于养老事业持续发展。

社区工作人手不足，对养老、医疗问题本身就不太专业，而日常培训工作又不到位，导致养老服务意识欠缺、效率较低，实际服务效果并不好，所以老年人对社区养老服务的评价普遍不高。同时像许多老年人的养老服务需求在半夜，经常需要人员轮流值守，工作强度和压力都很大，工作付出与期望待遇不一致，心里落差较大，基本上留不住人才。

(访谈对象，朝阳区 L 街道社区居委会工作人员，访谈时间 2021 年 6 月 21 日)

第五章 国内外社区嵌入式养老服务模式的经验借鉴

本章主要从日本、美国、上海等国内外较早开展社区养老服务的地区入手，有针对性介绍这些地区的探索创新亮点，总结出其实践成功的共性特征和发展启示，为北京市社区嵌入式养老服务模式中存在的问题寻求解决思路。

第一节 日本社区照护模式

日本是世界上最早进入老龄化的国家之一，早在 20 世纪中期就一直承受着巨大的养老压力。近年来，日本政府为应对严峻的人口老龄化问题，将老龄工作纳入社会经济发展规划，从 1986 年颁布《长寿社会对策大纲》，到 20 世纪八九十年代的“新旧黄金计划”，再到 2006 年对《老年人雇佣安定法》修订以及最近推出的“橙色计划”，已探索出比较成熟的社区照护养老道路。它在自身国土面积小，空间资源有限的情况下，以小规模多功能的老人福祉和收费老人之家等嵌入式设施作为激发养老潜力的载体，鼓励多方合作参与社区资源的规划布局、重组优化，在此基础上提供集日间照料、短期居住、医疗救助、定期巡视等与微型嵌入式设施相匹配的养老服务，构建全天候社区照护网络。此外，日本社区照护模式最大的亮点在于其完善的人才培养体系和志愿助老机制。从人才培养体系来看，日本有 400 多所护理福利专门学校，开设有专门的老年学专业并建立了严格的养老护理人员职业资格考试制度，以资格认证考试的方式规范养老服务行业准入门槛。从志愿助老机制来看，日本积极推进延长退休和老年人再就业政策。将退休年龄延长至 65 岁，同时对延迟退休的企业予以奖励和资助；政府创办高龄者雇佣开发协会，开展职业技能和择业求职培训，协助老年人进行再就业规划；社区成立“老年人人才中心”，提供公益慈善性工作，统筹老年人志愿服务活动。由此可见，日本社区照护模式不仅让老年人在熟悉的社区中实现人性化养老照护，而且通过多渠道拓展老年人再社会化，让老年人发挥余热回报社会，走上“以老助老”的良性轨道。

第二节 美国长期护理 PACE 模式

1970 年代，美国面对日益严重的社会老龄化问题，实施了一项基于医疗保险全面照顾的社区养老服务政策。PACE—Program of All-inclusive Care for the Elderly，译为“长者护理全包计划”。其主要内容是让 55 岁以上老年人在家中

接受所需的基本护理，由专车接送往返社区日间照料中心（ADHC），通过跨学科的职业护理团队为老年人在社区提供包括医疗复健、社交娱乐以及其他养老支持服务。其中，PACE 团队主要由 ADHC 中心的专职医护人员及其助手组成，例如：全科医生、护士、药剂师、理疗师、营养师、日常护理人员、社区工作者等，他们不仅可以提供专业的医疗护理服务，而且能对老年人的健康状况进行定期评估，以制定个性化的护理计划，最后直接跟老年人及其家属沟通选择最合适的实施方案。此外，PACE 团队还会每天严格按照实施方案跟踪服务进度，有针对性地派遣不同医护人员上门走访，随时动态调整方案，主动介入老年人健康管理全过程。1997 年，美国把长期护理 PACE 模式纳入《平衡预算法》（BBA）永久医疗保险项目，进一步将老年人的短期医疗与长期养老紧密地结合起来，即解决了老年人出行面临的行动不便难题，又能确保其医疗养老需求得到及时准确的响应和全面高效的满足，最大限度地延长了老年人在社区中生活的时间期限。经过多年实践 PACE 已经成为美国一种成功的养老服务模式，其医养结合的成功经验有许多值得我们借鉴之处。

第三节 上海长者照护之家模式

上海市作为我国第一个老龄化城市，也是我国最早开始探索和实践养老服务改革的地区之一。早在 2014 年，上海市就开始以“长者照护之家”为试点，突破超大型城市养老服务供给难题，随后针对社区嵌入式养老服务模式的核心概念、发展定位、服务类型以及其嵌入设施的建设标准、服务内容、人员配置、补贴金额等各方面出台相应政策。作为我国首个实施社区嵌入式养老服务模式的地区，上海市进行了诸多创新尝试，构建起社区养老“五大网络”：通过加强准入监管、日常监管、行业自律、社会监督，致力于形成完善的养老政策支撑网络；以养老设施布局专项规划为引领，扩大养老床位，社区适老化基础设施建设，大力发展符合超大城市特点的嵌入式养老设施网络；促进养老服务供给与需求有效对接、公平匹配，聚焦支付结算保障、医养结合、护理队伍建设、养老统一需求评估等四项短板重点突破，全面建立养老服务联盟网络；明晰政府与市场在社区养老领域的职责边界，充分调动社会力量参与养老志愿活动的积极性，发挥多元主体作用，构建紧密的社区信任关系网络；通过普及智能手环、多功能护理床、爬楼机等设备辅具，统筹全市一体化养老综合服务平台，各区“养老大数据中心”，街道社区内部的群组程序，推出一网覆盖的信息管理系统，打造科学高效的信息

技术网络。由此可见，上海市社区嵌入式养老服务模式能取得成功，得益于构建了紧密联系的养老结构网络体系，最大限度地盘活社区资源，激发养老服务市场活力，充分利用智慧化管理手段，动态精准地把握老年人有效需求，营造老年友好的社会氛围，促进社区嵌入式养老服务模式的高质量发展。

第四节 国内外社区嵌入式养老服务模式发展经验启示

尽管不同国家和地区的老齡人口数量、结构、收入及教育等方面存在差异，社会经济文化发展水平也不径相同，但通过对上述国家和地区的社区养老服务模式梳理，总结共性规律，找出值得北京市完善社区嵌入式养老服务模式的参考借鉴之处。

一、构建完善的养老政策体系，依法保障实施

纵观各地养老服务发展历程，不难看出每一个养老服务模式成功的背后都有一整套系统完善的养老政策体系做支撑。北京市社区嵌入式养老服务模式已进入深化发展期，但与国内外其他发达地区相比，政策制定及执行仍相对滞后，养老服务标准尚未完全统一，导致社区养老服务工作推进缓慢。为此，应学习和借鉴上述国家和地区在养老立法方面的先进政策成果，结合北京实际制定严格的制度规范，为今后社区嵌入式养老服务模式发展提供法律保障。

二、聚焦老年人的需求，提升养老服务满意度

从上述各地的具体实践来看，社区嵌入式养老服务模式与传统养老服务模式相比，无论是推行医养结合，还是打造智慧养老，其核心都是以老年人的需求为中心，构建多层次社区养老结构网络。实际上，只有聚焦社区不同老年群体及其养老需求，有针对性的提供差异化养老服务，才能让养老服务效果更显著。例如：按照老年人的生活习惯、照料需求、教育职业或兴趣爱好进行分类，将同类型的老年人吸引到一起，即有利于精准定位，提升养老服务的效率，也有助于加强老年人沟通与交往，形成良好的信任关系，减少养老工作开展的阻力。因此，对于养老服务而言，认识到老年人的多样性进而细分目标群体，是解决养老服务供需矛盾，全面提升养老服务满意度的关键所在。当前北京市在社区养老服务内容和种类上求新求全，重物质层面而轻精神层面，忽略了老年人的真实需求和感受，这种大水漫灌式养老供给方式容易造成供需脱节以及资源浪费，难以达到预期效果，需要及时转变服务理念，仔细聆听老年人的意见建议，以老年人需求为导向，精准高效提供个性化的养老服务。

三、重视养老服务人才培养

日本、美国等国家都十分重视养老服务人才培养，不仅建立学校，开设养老、医疗等相关专业，而且通过开展职业培训、举办技能竞赛、增加就业岗位、提高薪酬待遇等方式吸引更多优秀人才加入养老服务行业。反观目前北京市养老服务行业不但总体人数匮乏，而且很多从业者不具备医疗照护、救急抢险的基本知识和技能，大大制约了养老服务的质量提升。因此，要实现北京市社区嵌入式养老服务模式健康可持续发展，探索有效的养老服务人才培养和激励机制必不可少。

第六章 北京市优化社区嵌入式养老服务模式的对策

北京市在发展社区嵌入式养老服务模式过程中，应牢牢把握嵌入特性，围绕嵌入式养老设施、医养结合养老服务、社区老年参与、智慧化养老体系等具体内容，因地制宜，从统筹部门权责、完善政策体系、规范设施建设、优化服务网络、提升科技含量、充实资金人才等方面积极探索。为促进该模式健康持续发展，提出以下六个方面建议：

第一节 统筹部门权责和顶层设计

养老服务体系构建离不开政府宏观调控以及法律制度保障，因此，北京市想要实现社区嵌入式养老服务模式建设的稳步推进，需要从政府部门统筹协调和政策制定执行两个层面分别发力，相互配合，促进协同发展。

一、**落实部门权力责任，加强统筹协调。**明确政府各部门养老工作的具体职责，理顺各层级之间的沟通渠道，简化工作流程；由北京市卫健委牵头，财政、发改、住建、人社、应急等部门协同，成立养老服务联席会议，及时解决社区养老中遇到的问题；加快全市养老系统与医疗系统的联通融合，克服医养结合改革瓶颈。

二、**优化顶层制度设计，保证政策执行的持续稳定。**北京市应在国家十四五时期养老服务模式融合发展大框架下，结合首都人口老龄化、经济社会发展水平以及当前疫情防控情况等因素，推动养老服务规范化和法制化建设，特别是加强养老服务驿站的运营风险防控、医养结合养老服务综合监管以及老年人信息共享机制等方面的制度化建设。同时加大与社会养老保险、社会福利待遇、养老人才培养等法律制度的衔接，进一步提高社会养老政策保障能力；探索建立政府、企业、社会、家庭、个人多元主体之间的协同养老机制，促进彼此沟通交流，切实保障老年人相关的合法权益。

第二节 补齐社区嵌入式养老设施短板

由上文调研可以看出，北京市嵌入式养老设施网络已基本确立，但要使嵌入的养老设施更自然地存在于社区之中，关键在于夯实硬件基础，加强其与养老服务网络、社区关系网络、信息技术网络等的有效衔接，对社区原有公共基础设施，打磨适老化细节，提升无障碍品质，营造一个舒适安全的老年宜居环境。

一、优化嵌入式养老设施点位布局。在优化嵌入式养老设施布局时要明确区级养老指导中心、街乡养老照料中心、社区养老服务驿站等各级养老机构之间职能定位及服务半径，结合非首都功能疏解，提前规划、整体布局，实现设施配置与老年人口空间结构分布相匹配，重点消除“服务盲区”。

二、注重嵌入式养老设施功能及配套宣传。加大社区嵌入式养老服务模式的宣传力度，加深社区老年人对养老照料中心、养老服务驿站等养老机构及其服务功能的认识了解，逐步改变传统家庭养老观念，提高社区卫生服务中心、老年食堂、家庭照护床位等新型嵌入式养老设施使用率，避免资源闲置浪费。

三、加强老年人实际需求调研。要深入基层充分调研老年人的实际养老需求，认真听取他们的意见建议，根据老年人的身心特点和生活习惯，将“适老化”规划设计作为社区公共基础设施建设的普适性要求。针对问卷调查中老年人非常关心的社区治安、消防安全和交通出行等问题，在财政资金和经费有限的情况下，给予优先支持，从安装门禁和监控、增设消防安全设施、统一养老网点标识、疏通无障碍道路等细节入手，提升社区居住环境和交通出行的质量。

第三节 全面提升医养结合养老服务水平

养老服务是养老管理工作的重点，针对北京市目前医养结合的资源整合力度不够、养老服务供需不平衡等问题。重点要以养老需求为导向，创新养老服务供给内容和方式，完善养老服务网络，实现养老服务供需平衡。

一、优化养老供给渠道。首先，建立完善养老服务的需求调查、综合评估、巡访探视制度，对社区老年群体进行更细致的分类，精准识别老年人的消费需求、能力与意愿，推进养老产品或服务的差异化，提升供给的适配性、精准性。例如：经过综合评估，对失能、失智、重残等生活不能自理的老年人进行长期托养照护；对于残疾、高龄等行动不便的半自理老年人采取上门巡访探视、紧急救助等服务；而为空巢、失独、低龄等健康老年人提供日间生活照料、文体娱乐等服务，减少服务成本，提高服务效率；其次，鼓励社区养老机构运营商开展规模化、连锁化经营并链接辖区内养老、医疗、商业等各领域服务商，构建区域医养结合养老服务联合体，确保社区养老服务本身不偏离其公益属性；最后，加强养老服务与社区中的养老设施、老年活动、信息平台等各方面的无缝衔接，实现各种养老网络之间的联动，使养老服务供给更便捷，更有质量。

二、激活养老消费市场。首先，加强医养结合养老服务宣传教育，引导老年

人转变传统保守的消费观念，增强老年人消费意愿；其次，借助智慧化信息技术打造线上“菜单式”养老服务，使老年人由过去到社区被动选择养老服务转变为居家依据自身实际主动定制养老服务，进一步挖掘释放社区养老需求；最后，增加老年人的收入。统一规范养老津贴的适用人群、具体标准、发放方式等内容，提高低保、失独等特殊老年人的补助，使老年人收入水平与养老服务消费相契合，更好地撬动养老消费的市场。

第四节 推动养老互助和志愿活动

老年人退休后拥有大量的时间和精力，是社区养老中宝贵的资源财富。要注意引导老年人树立积极老龄观，培养自尊、自立、自强、自爱的意识，保持身心健康，乐观看待老年生活，主动参与社区活动，实现自身价值。

一、营造老有所乐的社区氛围。积极开展“魅力老人”、“银发达人”、“好家风好家训”等宣传评选，形成独具特色的社区老年活动，弘扬敬老爱老的孝义文化；增加老年教育培训机会，设立老年教育发展基金，充分发挥老年大学、养老服务驿站、社区公园等场地作用，定期开展安全教育、健康科普、电信诈骗、急救护理等方面的培训讲座，帮助老年人更好地融入社区生活。

二、打造老有所用的空间平台。广泛发展睦邻互助养老机制，制定老年“时间银行”政策，构建社区关系网络。推动社区根据实际需要设置老年志愿服务岗位，倡导低龄老年人参与帮扶高龄老年人的志愿服务，形成互帮互助、共建共享的互助养老新格局；大力培育养老服务公益慈善组织，引导老年协会、志愿者协会、红十字会、慈善协会等组织参与社区公益慈善活动，提升老年人对社会的认同感。

三、创造老有所为的就业环境。拓宽老年人就业信息渠道，搭建多元交流平台，给予老年人职业技能培训和规划指导，鼓励低龄健康老年人延迟退休、自主创业；推动用人单位与受聘老年人依法签订协议，保障老年人在劳动过程中的合法收入、人身安全和健康权益；同时注重发挥党建引领力量，加强社区党组织建设，凝聚基层党员，培育社区居民骨干，进一步发挥退休老年人在社区政策宣传、安全防范、防疫救灾等方面的作用，引导广大老年人增强主人翁意识，积极参与社区治理。

第五节 助力智慧赋能养老体系建设

当今科技进步日新月异,信息技术发展普及不仅为老年人的生活带来前所未有的便利,也为社区养老工作变革提供了新的契机。北京市要加强科技创新,将互联网以及人工智能的设备和技术融入社区,提高养老服务质量和养老工作效率,消除老年人与社会的数字鸿沟,建立智慧化养老新格局。

一、搭建统一的综合养老服务信息平台。加大对各街道养老服务信息平台统一整合,实现全市范围内老年人口基本信息、健康医疗、疾病防护等数据闭环管理,为提高养老服务效率、创新养老服务方式奠定基础。

二、利用信息平台打破数据壁垒。加强养老照料中心、养老服务驿站等社区微型养老机构与综合医院、养老院、诊所药店以及其他便利商店的信息连结,建立区域医养联盟综合体,打通各部门、各领域之间的网络端口壁垒,实现养老医疗数据互通和资源共享。

三、加强针对老年人数字化普及教育。提升老年人对线上网络 and 智能设备的使用能力,帮助其适应信息化社会。同时注重对老年人的人文关怀,为无法使用线上业务的特殊老年群体保留传统线下服务渠道。

第六节 打造多元的筹资方式和专业的人才队伍

社区嵌入式养老服务模式的发展离不开资金保障和人才培养,北京市凭借首都强大的经济、教育,医疗等领域实力,拥有高度发达的融资渠道和较丰富的高端人才,应注意充分整合现有资金和人力资源,重视人才引进与培养,为北京市养老事业科学可持续发展提供不懈动力。

一、多渠道筹集社区嵌入式养老服务模式建设资金,形成政府、企业、社会、家庭多方合作机制。一方面,社区嵌入式养老设施建设工作要积极争取财政、民政、发改、住建等多部门的支持,有效落实土地、规划、税费、水电等优惠政策,同时将社区老年活动经费纳入北京市一区两级年度财政预算,注重全市各街道经济发展水平和人口老龄化之间的差异,合理统筹财政资金支出,做到收支两条线,财权与事权匹配,防止财政资金闲置沉淀;另一方面,创建资金筹措的多方合作机制。充分利用财政资金的导向作用,加大金融企业的信贷支持力度,引导包括社会非营利组织、家庭以及个人等主体参与到社区嵌入式养老服务的运营及活动中,综合运用信贷抵押、税收奖励、财政贴息、区域经济发展调度资金等手段,使社区嵌入式养老服务模式的融资走上良性发展轨道。

二、加快养老服务人才队伍建设，提升社区养老服务人员素养。要提高养老服务人才薪酬待遇，拓展养老服务行业的晋升通道，改善社区养老工作环境，消除全社会对养老服务岗位的歧视，为养老服务人才职业发展创造良好的外部环境和条件；同时改善养老服务人员内部结构，在招聘时可更多向年轻、男性人员倾斜，使养老服务队伍的年龄、性别比例更加合理；加强企业、社区与院校合作，使理论与实践相结合，分类培育养老照料、医疗护理、心理慰藉等高学历的专业人才，形成层次分明的人才梯队；加大养老服务人才培训、养老扶持政策宣传，为医护人员跨界多点执业提供支撑；建立养老服务人才资格等级认证及信用评价体系，定期开展养老政策、医疗健康、急救护理等培训课程和技能竞赛，完善养老服务人才激励机制。

结论与展望

我国人口老龄化形势日趋复杂严峻,急需研究探索更加符合我国国情的社会化养老服务模式。社区嵌入式养老服务模式继承了传统家庭、机构、社区居家等养老服务模式的优势,又结合当前我国城市发展转型过程中资源紧张的实际情况进行了大胆的创新。通过采取政府主导、多元主体协同参与的形式,将养老资源进行有效整合嵌入社区,在此基础上精准地为老年人提供医养结合养老服务,借助丰富的社区参与活动和便捷的信息技术应用,构建起多层次的社区养老结构网络,促使养老服务模式与社区有机融合,从而实现老年人“原居安养”的愿望。北京市作为我国最早开展社区嵌入式养老服务模式的地区之一,取得了一定的成绩,同时也存在一些问题。为此,本文选择北京市朝阳区作为研究样本,进行了深入的研究探讨。大体结论如下:

首先,经济发展的根本目的就是增进民生福祉,养老服务作为民生领域中的重要组成部分,关系着社会稳定和国家长治久安。社区嵌入式养老服务模式的推出,即是由于我国人口老龄化的现实需要,也与该模式自身具有的优势密不可分。本文运用福利多元主义、嵌入性治理等理论作为分析依据,按照社区嵌入式养老服务模式的基本要素和主要特征从嵌入式养老设施、医养结合养老服务、社区老年参与、智慧化养老体系等四个维度出发设计访谈提纲和调查问卷,为下一步的实地调研奠定基础。

其次,经过对朝阳区四个街道进行实地走访后,发现北京市凭借其雄厚的经济、医疗、科技、教育实力,基本实现全市嵌入式养老设施网络全覆盖,医养结合逐步深化,养老服务功能不断升级,服务范围由社区向家庭延伸,社区内精神文化及志愿服务活动日趋丰富,各街道基于互联网和人工智能设备建设的养老信息平台也已初具雏形。但从基层老年工作人员访谈以及老年人问卷调查情况来看,各种类型养老结构网络之间仍无法有效衔接,养老服务的供给与老年人的实际需求脱节,现阶段嵌入式养老服务模式尚未与社区形成紧密的联系。主要表现在:政府统筹协调以及政策制定执行不到位、嵌入式养老设施整合错位、医养结合养老服务供需失衡、社区老年参与水平不高、智慧化养老尚未真正智能、养老资金和人才队伍缺乏等方面。对于这些不足笔者认为,第一是由于当前社区嵌入式养老服务模式处于发展的初期阶段,许多养老工作尚未落实到位所致;第二是社会各界对养老重视度不够,导致社区嵌入式养老服务模式的建设缺乏全局性、

前瞻性和预见性；第三是养老的资金和人才等相关配套支持还不完善。

最后，通过上述综合分析，结合日本、美国和上海等国内外发达国家地区养老实践经验，总结出完善的政策法律体系、精准的需求定位以及养老专业人才培养对社区嵌入式养老服务模式的发展也发挥着十分重要的作用。因此，从统筹部门权责和顶层设计、补齐社区嵌入式养老设施短板、全面提升医养结合养老服务水平、推动养老互助与志愿活动、加强智慧赋能养老体系建设、打造多元的筹资方式和专业人才队伍等方面，为完善北京市社区嵌入式养老服务模式提出对策建议。希望本文能够丰富已有的相关学术研究成果，并且对我国实际推广社区嵌入式养老服务模式提供一些参考借鉴。

由于本人的时间精力和研究水平有限，在研究过程中仍然存在不足，北京市作为我国首都，拥有强大的经济、医疗、教育、科技实力，人口老龄化情况也更为复杂，因此，北京市的社区嵌入式养老服务模式具有鲜明的特色优势，各地在建设社区嵌入式养老服务模式时，还需要根据自身实际情况，进行因地制宜的探索和尝试。

养老服务高质量发展是实施积极应对人口老龄化的内在要求和关键环节。

“十四五”时期是实施积极应对人口老龄化国家战略的第一个五年，也是养老服务高质量发展的战略机遇期。随着我国养老服务体系改革的深化以及社会对养老服务观念的转变，相信社区嵌入式养老服务模式未来还有巨大的发展提升空间，需要我们进一步解放思想、统筹协调多元主体加强合作，打破养老设施网络、养老服务网络、社区关系网络、信息技术网络之间壁垒，稳步推进社区养老事业发展，为老年人健康安享晚年提供一个幸福舒适的环境。

参考文献

- [1] 国家统计局官网. 第七次全国人口普查公报 (第五号) [EB/OL]. http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/rkpcgb/qgrkpcgb/202106/t20210628_1818824.html. 发布时间 2021 年 5 月 11 日.
- [2] 习近平. 决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[M]. 北京: 人民出版社 2017 年版, 48.
- [3] 北京市人民政府官网. 北京市第七次全国人口普查公报 (第三号) [EB/OL]. http://www.beijing.gov.cn/gongkai/shuju/sjgd/202105/t20210519_2392888.html. 发布时间 2021 年 5 月 19 日.
- [4] 张琪,张栋. 北京市“9064”养老格局的适应性研究[M]. 北京: 中国劳动社会保障出版社 2014 年版, 28.
- [5] 北京朝阳官方发布. 北京市朝阳区第七次全国人口普查公报[EB/OL]. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1702165333860743053&wfr=spider&for=pc>. 发布时间 2021 年 6 月 10 日.
- [6] 黄石松. 养老服务体系建设——北京的探索与实践[M]. 北京: 中国社会科学出版社 2019 年版, 228.
- [7] 章萍. 嵌入式养老: 上海养老服务模式创新研究 [J]. 现代管理科学, 2016(06):64-66.
- [8] 上海市民政局官网. 关于引发《上海市社区嵌入式养老服务工作指引》的通知[EB/OL]. http://mzj.sh.gov.cn/MZ_zhuzhan279_0-2-8-15-55-231/20200519/MZ_zhuzhan279_47550.html. 发布时间 2019 年 11 月 19 日.
- [9] 天津市民政局官网. 关于推进社区嵌入式养老服务机构发展的指导意见 [EB/OL]. http://mz.tj.gov.cn/ZWKG5878/ZCFG9602/zcwj/202112/t20211230_5766473.html. 发布时间 2021 年 12 月 30 日.
- [10] Sharfstein.S, Nafziger.J.C. Community Care :Costs and Benefits for a Chronic Patient[J]. Psychiatric services, 1976, (27):170-173.
- [11] Newcomer.R, Arnsberger.P, zhang.X. Case management , clint risk factors, and service use[M]. Health Care Finacing Review, 1997, 19(1):pp.105-120.
- [12] Boulton. C, Rassen.J, Rassen.A, et al. The effect of case management on the costs of

health care for enrollees in medicare plus choice plans: A randomized trial[J]. journal of the American Geriatrics society, 2000, 48(8):996-1001.

[13] Evashwick, Connie, ed. The continuum of long-term care: An integrated systems approach[J]. Cengage Learning, 1996.

[14] Challis.D, Davies.B. Long-term care for the elderly:the community care scheme[J]. british journal of social work ,1985, 15(6):563-779.

[15] Hulme G. Griffiths on community care[J]. Public Money & Management, 1988, 8(1-2): 65-68.

[16] Hillel Schmid . The Israeli long -term care insurance law:selected issues in providing home care services to the frail elderly[J]. Health and social care in the community , 2004, 13(3):191-200.

[17] Cott C.A, Falter L.B, GignacM, et al . Helping networks in community home care for the elderly:types of team can [J].Nurs, 2008, 40(1):30-37.

[18] Sherry Anne Chapman, et al. Client -centred, community-based care for frail seniors[J]. health and social care in the community , 2002, 11(3):256-261.

[19] 胡宏伟,汪钰,王晓俊,张澜. “嵌入式”养老模式现状、评估与改进路径[J].社会保障研究,2015(02):10-17.

[20] 赵小兰,孟艳春.社区“嵌入式”养老服务模式:优势、困境与出路[J].河北大学学报(哲学社会科学版),2019,44(04):89-95.

[21] 闫小红.社会资本理论视角下家庭养老替代模式选择及路径构建——以济南市 D 社区综合养老服务中心个案研究为例[J].广西社会科学,2020(04):73-78.

[22] 穆光宗.美国社区养老模式借鉴[J].人民论坛,2012(22):52-53.

[23] 康越.日本社区嵌入式养老发展历程及其经验[J].北京联合大学学报(人文社会科学版),2017,15(04):110-117.

[24] 钟慧澜,章晓懿.从国家福利到混合福利:瑞典、英国、澳大利亚养老服务市场化改革道路选择及启示[J].经济体制改革,2016(05):160-165.

[25] 陈醉. 上海社区嵌入式养老的创新经验[J].党政论坛,2020(01):37-40.

[26] 郝勇, 骆潇蔓. 上海市社区嵌入式养老服务模式发展管窥[J].城市观察,2021(04):125-135.

[27] 陈岩,方媛,张洋,甘珍珍,梁会东.社区嵌入式养老服务供给与功能优化研究——以上海市为例[J].老龄科学研究,2021,9(08):55-66.

- [28] 周悦,崔炜.北京市嵌入式养老模式发展研究——以养老服务驿站为例[J].新视野,2019(04):90-96.
- [29] 徐旭,吴梦园,郭婷,李恩宏.天津市嵌入式养老模式的构建研究[J].中华护理杂志,2018,53(S1):84-89.
- [30] 宋晓宇.上海社区嵌入式养老发展现状及建议[J].科学发展,2020(09):107-113.
- [31] 朱勤皓.上海社区嵌入式养老服务发展的探索与思考[J].中国民政,2017(16):30-32.
- [32] 郭晓敏.社区嵌入式养老模式发展路径研究——基于合肥市的实践探索[J].重庆科技学院学报(社会科学版),2018(06):28-31.
- [33] 安炳辉.社区嵌入式养老模式问题与改进路径研究[J].广西经济管理干部学院学报,2020,32(01):7-11.
- [34] 王晶,李鹏飞.社区嵌入式养老服务模式的优势与思考——基于发达地区与欠发达地区养老服务现状的考察[J].吉林大学社会科学报,2019,59(06):133-139+222.
- [35] 张仁枫,苑港华.新时代城市社区嵌入式养老研究热点与趋向(2012-2020)——基于 Citespace 的文献计量分析[J].中共成都市委党校学报,2020(05):76-82.
- [36] J.Wolfenden. The Future of Voluntary Organizations[M]. London: Croom Helm, 1978, pp.9-14.
- [37] R.Rose. Common Goals But Different Roles: the State' s Contrintion to the Welfare Mix, in R.Rose&R.Shiratori. The Welfare State East and West [M]. Oxford: Oxford University Press ,1986, pp.13-39.
- [38] A.Evers. Shifts in the Welfare Mix: Introducing A New Approach for the Study of Transformations in Welfare and Social Policy.in A.Evers &H.Wintersberger(eds.),Shifts in the Welfare Mix:Their Impact on Work. Social Services and Welfare Policies[M]. Bloomington: Campus Verlag, 1990, pp.7-30.
- [39] Johnson,N. The Welfare State in Transition :The Theory and Practice of Welfarepluralism[M]. Amherst :University Massachusetts Press, 1987.
- [40] 周富玲.上海市社区嵌入式养老服务可及性研究[D].华东师范大学,2020.
- [41] K.Polanyi. The Great Transformation: The Political and Economic of Our Time[M]. Boston, MA : Beacon Press, 1944, pp.126.
- [42] M.Granovetter. Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness[M]. American Journal of Sociology, vol.91, no.3 (1985) , pp.486- 490.

- [43] 朱浩.社区嵌入式养老服务的社会化运作机制及其实践逻辑[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2020,37(05):98-106.
- [44] 刘亚娜, 谭晓婷, 陈望宇. 嵌入—融合—互嵌: 我国社区居家养老发展路径——“机构养老社区化”+“社区养老机构化”[J].理论界,2019(10):74-79.
- [45] 北京市发改委官网. 北京市切实解决老年人运用智能技术困难 10 余项工作取得阶段性成果[EB/OL]. http://fgw.beijing.gov.cn/gzdt/fgzs/mtbdx/bzwlxw/202109/t20210902_2482450.htm. 发布时间: 2021 年 9 月 1 日.
- [46] 北京市民政局官网. 北京市老龄工作委员会印发《关于开展社区养老服务驿站建设的意见》[EB/OL]. http://mzj.beijing.gov.cn/art/2016/5/18/art_6112_11724.html. 发布时间 2016 年 5 月 18 日.
- [47] 北京市人民政府官网. 北京市民政局关于印发《社区养老服务驿站设施设计和服务标准(试行)》的通知[EB/OL]. http://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/201905/t20190522_59687.html. 发布时间 2016 年 10 月 17 日.
- [48] 北京市人民政府官网. 北京市人民政府办公厅转发卫生计生委等部门《关于推进医疗卫生与养老服务相结合的实施意见》[EB/OL]. http://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/201905/t20190522_59748.html. 发布时间 2016 年 12 月 8 日.
- [49] 北京市人民政府官网. 北京市民政局北京市规划和自然资源委员会关于印发《北京市养老服务专项规划(2021—2035 年)的通知》[EB/OL]. http://www.beijing.gov.cn/zhengce/gfxwj/202109/t20210930_2505867.html. 发布时间 2021 年 9 月 29 日.
- [50] 北京市民政局官网. 北京市民政局, 财政局, 卫生健康委员会, 医疗保障局, 残疾人联合会关于印发《北京市养老家庭照护床位建设管理办法(试行)》的通知[EB/OL]. http://mzj.beijing.gov.cn/art/2021/4/7/art_4492_14170.html. 发布时间 2021 年 3 月 26 日.
- [51] 北京市人民政府官网. 关于切实解决养老领域老年人运用智能技术困难有关工作的通知[EB/OL]. http://www.beijing.gov.cn/ywdt/jiedu/zxjd/202012/t20201221_2169726.html. 发布时间 2021 年 12 月 21 日.
- [52] 北京市人民政府官网. 北京市文物局转发市老龄委《关于开展“智慧助老”系列公益视频和小程序宣传推广的通知》的通知[EB/OL]. <http://wwj.beijing.gov.cn/bjww/362679/362686/10915957/index.html>. 发布时间 2021 年 1 月 6 日.
- [53] 北京市卫生健康委员会官网. 北京市老龄事业发展报告(2020)[EB/OL].

http://wjw.beijing.gov.cn/xwzx_20031/xwfb/202110/t20211014_2512063.html. 发布时间 2021 年 10 月 24 日.

[54] 解芳芳,朱喜钢.中日社区居家养老模式对比研究——基于社会嵌入理论视角[J].中国名城,2016(11):75-82.

[55] 成秋嫻,冯泽永.美国 PACE 及其对我国社区医养结合的启示[J].医学与哲学(A),2015,36(09):78-80+88.

[56] 朱勤皓等.大城养老——上海的实践样本[M].上海:上海人民出版社 2017 年版. 3.

[57] 闫萍,董亭月.北京养老服务要破解五大难题[J].前线,2021(03):79-82.

[58] 陆洁如.嵌入式社区居家养老服务模式构建研究[D].吉林大学,2020.

[59] 张婷婷.政府购买服务背景下嵌入式养老模式研究[D].山东大学,2021.

[60] 陈建领,成海军,邱维伟.北京市社区养老服务驿站的运营模式、服务特点及发展建议[J].中国民政,2021(12):42-45.

[61] 王伟进.中国社区养老的实践探索与整合发展路径[M].北京:社会科学文献出版社 2019 年版.

[62] 汪连新.城市城区养老服务研究——基于北京市的实证调查[M].北京:中国社会科学出版社 2015 年版.

[63] 国务院发展研究中心社会部课题组.养老服务体系发展的国际经验与中国实践[M].北京:中国发展出版社 2019 年版.

附录一

北京市朝阳区社区嵌入式养老服务需求调查问卷

您好,为进一步了解北京市朝阳区社区嵌入式养老服务模式建设状况,特开展本次调查,希望能收集您对社区养老的需求和建议,请您根据实际情况和真实感受认真填写,在下面的编号中打勾。非常感谢!

基本信息情况:

1.您的年龄是【单选】

编号	选项	
1	60 岁以下	终止访问
2	60 岁—65 岁	继续访问
3	65-70 岁	
4	70 岁以上	

2.您的性别是【单选】

编号	选项
1	男
2	女

3.您家庭的子女情况【填空】_____位儿子，_____位女儿。

4.您现在的居住情况是【单选】

编号	选项	编号	选项
1	与老伴、子女一起居住	4	空巢独居
2	仅与老伴居住	98	其他【请注明】_____
3	仅与子女居住		

5.您的受教育情况是【单选】

编号	选项	
1	初中及以下	
2	高中	
3	本科	
4	研究生及以上	
98	其他【请注明】_____	

6.您的健康状况是【单选】

编号	选项	编号	选项
1	健康	4	失能（失智）
2	患有慢性疾病	5	残疾人
3	患有重大疾病	98	其他【请注明】_____

7.您平时日常时间主要在做什么【限选三项】

编号	选项	编号	选项
1	家务劳动	5	志愿服务
2	照看小孩	6	旅游出行
3	运动健身	98	其他【请注明】_____
4	休闲娱乐		

问卷内容:

1.您认为社区提供以下方面的配置重要吗? 【单选】

编号	选项	非常重要	比较重要	一般	不太重要	不重要
		5	4	3	2	1
1	社区对住宅内安装扶手、抓杆、烟雾报警器等适老化装置;对地面进行防滑改造					
2	社区定期对供水、供电和供气等管道进行安全检查,及时更换维修老化损坏零件,配备消防、监控以及门禁等安全设施					
3	街道及社区开设养老照料中心、老年服务驿站、卫生服务中心、老年食堂等机构					
4	社区周边老年公寓、养老院、敬老院、综合性医院、诊所药店以及便利店等配套					
5	社区消除门槛,增加坡道、电梯、爬楼机、扶手、座椅等无障碍设施					
6	社区设置人车分流道,交通安全指示牌和夜间照明灯等设施					
7	社区为您签约驻家医生,提供医疗护理、体检保健、上门巡诊等医疗服务					
8	社区有机构或专人为您提供助餐助浴、家政保洁、托养照料、代购上门等养老生活服务					
9	社区设立心理咨询室,提供心理咨询和情感陪伴服务					
10	社区设立法务服务室,提供法律咨询和援助服务					
11	参与社区的居民代表会议、听证会等活动,提供再就业的职业规划和技术指导					
12	社区内提供公共的休闲娱乐活动场所,组织老年协会团体,开展各种文化体育活动					

13	社区设立公益志愿服务岗位，开展公益、慈善等志愿活动，组织老年人互帮互助					
14	社区设立老年教育学习点或老年大学，定期开展消防安全、健康科普、防盗防诈、紧急救助、养老护理技能等方面的培训讲座					
15	社区开展例如“魅力老人”、“银发达人”、“好家风好家训”等敬老宣传评选活动					
16	通过智能手环、手机平板、电脑等设备可以对您进行实时动态监控，提供居家照料、医疗诊断、紧急救助、健康养生等远程服务					
17	社区开设网络软件、手机电脑等智能技术和设备使用课程或派专人指导您学习数字化操作					
18	在社区办公场所办理日常业务时为您保留传统线下人工服务					

2.除上述外，您认为社区还有哪些方面的配置比较重要？

如有，请填写_____

3.请问您对建设社区嵌入式养老服务模式还有什么其他的意见或建议？

如有，请填写_____

问卷结束，祝您生活愉快!

附录二

北京市朝阳区社区嵌入式养老服务模式建设情况访谈提纲

一、朝阳区政府部门负责养老事务人员访谈提纲

- 1.请简要介绍朝阳区老年人口的基本情况；
- 2.请简要介绍朝阳区养老体系和社区嵌入式养老服务模式建设的总体情况；
- 3.请简要介绍朝阳区嵌入式养老设施规划布局的基本情况；
- 4.请简要介绍朝阳区医养结合养老服务的推进情况；
- 5.请简要介绍朝阳区在保障社区养老工作资金的政策措施有哪些；
- 6.请简要介绍朝阳区在发展社区嵌入式养老服务模式中存在的主要问题有哪些；
- 7.请简要介绍朝阳区对社区嵌入式养老服务模式建设有哪些成功的做法和经验；
- 8.请简要介绍朝阳区对社区嵌入式养老服务模式发展的下一步计划及建议。

二、街道办事处和社区居委会工作人员访谈提纲

- 1.请简要介绍贵街道（社区）的老年人口的基本情况；
- 2.请简要介绍贵街道（社区）养老工作开展的整体情况；
- 3.请简要介绍目前贵街道（社区）养老照料中心、养老服务驿站等机构建设情况；
- 4.贵街道（社区）对医养结合养老服务具体推进情况；
- 5.贵街道（社区）有哪些社区老年文体娱乐和公益志愿活动，老年人的参与情况如何；
- 6.贵街道（社区）有无智慧化养老信息技术系统，目前使用状况如何；
- 7.贵街道（社区）对社区养老工作中的主要困难及下一步工作打算；
- 8.贵街道（社区）对优化社区嵌入式养老服务模式建设的意见和建议。